



UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ – UNIOESTE
CENTRO DE EDUCAÇÃO, LETRAS E SAÚDE – CELS
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENSINO
- MESTRADO/ PPGEn
ÁREA DE CONCENTRAÇÃO:
CIÊNCIAS, LINGUAGENS, TECNOLOGIAS E CULTURA
LINHA DE PESQUISA: ENSINO, LINGUAGENS E FORMAÇÃO DE
PROFESSORES

ANA CAROLINE MAES CARRASCO

PERCEPÇÃO DO ACADÊMICO DE ENFERMAGEM SOBRE A TEMÁTICA DA
SEGURANÇA DO PACIENTE

FOZ DO IGUAÇU – PR
2026



UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ – UNIOESTE
CENTRO DE EDUCAÇÃO, LETRAS E SAÚDE – CELS
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENSINO MESTRADO/ PPGEn
ÁREA DE CONCENTRAÇÃO:
CIÊNCIAS, LINGUAGENS, TECNOLOGIAS E CULTURA
LINHA DE PESQUISA: ENSINO, LINGUAGENS E FORMAÇÃO DE
PROFESSORES

ANA CAROLINE MAES CARRASCO

PERCEPÇÃO DO ACADÊMICO DE ENFERMAGEM SOBRE A TEMÁTICA DA
SEGURANÇA DO PACIENTE

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Ensino – Mestrado - PPGEN, área de concentração: Ciências, Linguagens, Tecnologias e Cultura, linha de pesquisa: Ensino, Linguagens e Formação de Professores, da Universidade Estadual do Oeste do Paraná/UNIOESTE – Campus de Foz do Iguaçu, como requisito parcial para obtenção do título de Mestre(a) em Ensino.

Orientador(a): Prof.º Dr.º Reinaldo Antonio Silva-Sobrinho

FOZ DO IGUAÇU – PR
2026

FICHA CATALOGRÁFICA

Ficha de identificação da obra elaborada através do Formulário de Geração Automática do Sistema de Bibliotecas da Unioeste.

Carrasco, Ana Caroline Maes

Percepção do acadêmico de Enfermagem sobre a temática da segurança do paciente / Ana Caroline Maes Carrasco; orientador Prof.º Dr.º Reinaldo Antônio Silva Sobrinho. -- Foz do Iguaçu, 2026.
57 p.

Dissertação (Mestrado Acadêmico Campus de Foz do Iguaçu)
-- Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Centro de Educação, Programa de Pós-Graduação em Ensino, 2026.

1. Percepção. 2. Estudantes de Enfermagem. 3. Segurança do Paciente. 4. Ensino Superior. I. Sobrinho, Prof.º Dr.º Reinaldo Antônio Silva, orient. II. Título.

TERMO DE APROVAÇÃO (PÓS-DEFESA)



unioeste

Universidade Estadual do Oeste do Paraná
Reitoria
CNPJ 78.680.337/0001-84
Rua Universitária, 1619, Jardim Universitário
Tel.: (45) 3220-3000 - www.unioeste.br
CEP: 85819-110 - Cx. P.: 701
Cascavel - PARANÁ



ANA CAROLINE MAES CARRASCO

PERCEPÇÃO DO ACADÊMICO DE ENFERMAGEM SOBRE A TEMÁTICA DA SEGURANÇA DO PACIENTE.

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Ensino em cumprimento parcial aos requisitos para obtenção do título de Mestra em Ensino, área de concentração Ciências, Linguagens, Tecnologias e Cultura, linha de pesquisa Ensino, Linguagens e Formação de Professores, APROVADO(A) pela seguinte banca examinadora:

Orientador(a) - Reinaldo Antonio da Silva Sobrinho

Universidade Estadual do Oeste do Paraná - Campus de Foz do Iguaçu (UNIOESTE)

ADRIANA
ZILLY:022
69514998

Adriana Zilly

Universidade Estadual do Oeste do Paraná - Campus de Foz do Iguaçu (UNIOESTE)

Documento assinado digitalmente
RODRIGO JULIANO GRIGNET
Data: 05/03/2026 10:46:26-0300
Verifique em <https://validar.jb.gov.br/>

Rodrigo Juliano Grignet

Universidade Federal da Integração Latino-Americana (Unila)

Foz do Iguaçu, 5 de março de 2026

CARRASCO, Ana Caroline Maes. **Percepção do acadêmico de Enfermagem sobre a temática da segurança do paciente. 2026.** 59 f. Dissertação (Mestrado em ENSINO). Programa de Pós-Graduação em ENSINO. Área de concentração: Ciências, Linguagens, Tecnologias e Cultura. Linha de Pesquisa: Ensino, Linguagens e Formação de Professores. Universidade Estadual do Oeste do Paraná - UNIOESTE, Foz do Iguaçu, 2026.

RESUMO

A segurança do paciente é um pilar da qualidade da assistência em saúde e foi fortalecida no Brasil com a criação do Programa Nacional de Segurança do Paciente (Portaria nº 529/2013), que recomenda sua inserção na formação dos profissionais de saúde. Contudo, ainda existem desafios para integrar esse tema de forma contínua e prática nos currículos, o que pode limitar o desenvolvimento de uma cultura de segurança e aprendizagem a partir dos erros. O presente estudo tem como objetivo compreender a percepção do acadêmico de Enfermagem acerca da segurança do paciente no contexto de seu processo formativo. Trata-se de um estudo observacional, transversal, de abordagem quantitativa e caráter descritivo-analítico, realizado com estudantes de Enfermagem do 3º ao 5º ano da Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste). Utilizou-se questionário estruturado com variáveis sociodemográficas e quatro domínios relacionados à segurança do paciente, respondidos em escala Likert de cinco pontos. Os dados foram analisados no software R por meio de estatística descritiva, testes de Wilcoxon e Kruskal-Wallis e regressão linear simples. Participaram do estudo 39 acadêmicos de Enfermagem, majoritariamente do sexo feminino (76,92%) e com idade entre 18 e 25 anos (87,18%). De modo geral, observou-se percepção positiva sobre a segurança do paciente, com médias superiores a 3,5 na maioria dos itens avaliados. O item com maior média foi “A discussão sobre erros em sala de aula ou durante o estágio é importante para melhorar minha prática” (média = 4,67), enquanto o menor valor foi observado no item “Profissionais de saúde comprometidos não cometem erros” (média = 2,26), indicando reconhecimento da possibilidade de falhas na prática assistencial. A percepção sobre as condições dos ambientes de estágio para promoção da segurança apresentou média de 3,00, sugerindo avaliação ambivalente. Os escores médios por domínio variaram de 3,63 a 4,14, e não foram observadas associações estatisticamente significativas entre o escore total de percepção e as variáveis sociodemográficas analisadas ($p > 0,05$). Conclui-se que os acadêmicos de Enfermagem apresentam percepção positiva sobre a segurança do paciente e reconhecem sua importância para a qualidade da assistência. Os estudantes valorizam a discussão de erros como estratégia de aprendizado, porém a abordagem do tema ao longo da formação ainda ocorre de forma heterogênea, indicando a necessidade de maior integração da segurança do paciente no currículo.

Palavras-Chave: Percepção; Estudantes de Enfermagem; Segurança do Paciente; Ensino Superior; Educação em Enfermagem.

CARRASCO, Ana Caroline Maes. **Percepção do acadêmico de Enfermagem sobre a temática da segurança do paciente. 2026.** 59 f. Dissertação (Mestrado em ENSINO). Programa de Pós-Graduação em ENSINO. Área de concentração: Ciências, Linguagens, Tecnologias e Cultura. Linha de Pesquisa: Ensino, Linguagens e Formação de Professores. Universidade Estadual do Oeste do Paraná - UNIOESTE, Foz do Iguaçu, 2026.

ABSTRACT

Patient safety is a fundamental pillar of healthcare quality and has been strengthened in Brazil with the creation of the National Patient Safety Program (Ordinance No. 529/2013), which recommends its inclusion in the education of health professionals. However, challenges remain in integrating this topic continuously and practically into curricula, which may limit the development of a safety culture and learning from errors. This study aims to understand nursing students' perceptions of patient safety within the context of their educational process. This is an observational, cross-sectional study with a quantitative and descriptive-analytical approach, conducted with nursing students from the 3rd to the 5th year at the Western Paraná State University (Unioeste). A structured questionnaire was used, including sociodemographic variables and four domains related to patient safety, answered on a five-point Likert scale. Data were analyzed using the R software through descriptive statistics, Wilcoxon and Kruskal-Wallis tests, and simple linear regression. The study included 39 nursing students, predominantly female (76.92%) and aged between 18 and 25 years (87.18%). Overall, a positive perception of patient safety was observed, with mean scores above 3.5 in most evaluated items. The item with the highest mean score was "Discussing errors in the classroom or during clinical training is important to improve my practice" (mean = 4.67), while the lowest score was observed for "Committed healthcare professionals do not make errors" (mean = 2.26), indicating recognition of the possibility of failures in healthcare practice. Perception regarding the adequacy of clinical training environments to promote patient safety showed a mean score of 3.00, suggesting an ambivalent evaluation. Mean scores across domains ranged from 3.63 to 4.14, and no statistically significant associations were found between the total perception score and the analyzed sociodemographic variables ($p > 0.05$). It is concluded that nursing students have a positive perception of patient safety and recognize its importance for the quality of care. Students value the discussion of errors as a learning strategy; however, the approach to this topic throughout their education still occurs heterogeneously, indicating the need for greater integration of patient safety into nursing curricula.

Keywords: Perception; Nursing Students; Patient Safety; Higher Education; Nursing Education.

CARRASCO, Ana Caroline Maes. **Percepção do acadêmico de Enfermagem sobre a temática da segurança do paciente. 2026.** 59 f. Dissertação (Mestrado em ENSINO). Programa de Pós-Graduação em ENSINO. Área de concentração: Ciências, Linguagens, Tecnologias e Cultura. Linha de Pesquisa: Ensino, Linguagens e Formação de Professores. Universidade Estadual do Oeste do Paraná - UNIOESTE, Foz do Iguaçu, 2026.

RESUMEN

La seguridad del paciente constituye un pilar fundamental de la calidad de la atención en salud y se ha fortalecido en Brasil con la creación del Programa Nacional de Seguridad del Paciente (Portaria nº 529/2013), que recomienda su inclusión en la formación de los profesionales de la salud. Sin embargo, aún existen desafíos para integrar este tema de manera continua y práctica en los planes de estudio, lo que puede limitar el desarrollo de una cultura de seguridad y el aprendizaje a partir de los errores. El presente estudio tiene como objetivo comprender la percepción de los estudiantes de Enfermería acerca de la seguridad del paciente en el contexto de su proceso formativo. Se trata de un estudio observacional, transversal, de enfoque cuantitativo y carácter descriptivo-analítico, realizado con estudiantes de Enfermería de 3º a 5º año de la Universidad Estatal del Oeste de Paraná (Unioeste). Se utilizó un cuestionario estructurado con variables sociodemográficas y cuatro dominios relacionados con la seguridad del paciente, respondidos en una escala Likert de cinco puntos. Los datos fueron analizados mediante el software R utilizando estadística descriptiva, pruebas de Wilcoxon y Kruskal-Wallis y regresión lineal simple. Participaron en el estudio 39 estudiantes de Enfermería, predominantemente mujeres (76,92%) y con edades entre 18 y 25 años (87,18%). En general, se observó una percepción positiva sobre la seguridad del paciente, con medias superiores a 3,5 en la mayoría de los ítems evaluados. El ítem con mayor media fue “La discusión de errores en el aula o durante las prácticas clínicas es importante para mejorar mi práctica” (media = 4,67), mientras que el menor valor se observó en el ítem “Los profesionales de salud comprometidos no cometen errores” (media = 2,26), lo que indica reconocimiento de la posibilidad de fallas en la práctica asistencial. La percepción sobre las condiciones de los escenarios de práctica para promover la seguridad del paciente presentó una media de 3,00, sugiriendo una evaluación ambivalente. Los puntajes medios por dominio variaron entre 3,63 y 4,14, y no se observaron asociaciones estadísticamente significativas entre el puntaje total de percepción y las variables sociodemográficas analizadas ($p > 0,05$). Se concluye que los estudiantes de Enfermería presentan una percepción positiva sobre la seguridad del paciente y reconocen su importancia para la calidad de la atención. Los estudiantes valoran la discusión de errores como estrategia de aprendizaje; sin embargo, el abordaje del tema a lo largo de la formación aún ocurre de manera heterogénea, lo que indica la necesidad de una mayor integración de la seguridad del paciente en el currículo de Enfermería.

Palabras clave: Percepción; Estudiantes de Enfermería; Seguridad del Paciente; Educación Superior; Educación en Enfermería.

LISTA DE TABELAS

Tabela	Título	Pág.
Tabela 1	Caracterização sociodemográfica dos estudantes de enfermagem, Foz do Iguaçu, Paraná, 2025.	18
Tabela 2	Medidas-resumo da escala Likert por item e por domínio, de acordo com as respostas dos estudantes de enfermagem, Foz do Iguaçu, Paraná, 2025.	18
Tabela 3	Estimativas do modelo de regressão linear simples para a variável resposta “escore total” em função dos fatores sociodemográficos dos estudantes de Enfermagem, Foz do Iguaçu, Paraná, 2025.	22

LISTA DE FIGURAS

Imagem	Título	Pág.
Figura 1	Figura 1. Boxplot dos escores médios de cada domínio, com base nas respostas dos estudantes de enfermagem, Foz do Iguaçu, Paraná, 2025.	20
Figura 2	Figura 2. Boxplot dos escores totais entre os fatores sociodemográficos dos estudantes de enfermagem, Foz do Iguaçu, Paraná, 2025.	21

LISTA DE ABREVIATURAS, SIGLAS E ACRÔNIMOS

Siglas	Significado
CEP	Comitê de Ética em Pesquisa (com Seres Humanos)
DCN	Diretrizes Curriculares Nacionais
IOM	Institute of Medicine
IRAS	Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde
NSP	Núcleo de Segurança do Paciente
NOTIVISA	Sistema de Notificações em Vigilância Sanitária
OMS	Organização Mundial da Saúde
PNSP	Programa Nacional de Segurança do Paciente
PPGE	Programa de Pós-Graduação em Ensino
QR Code	Quick Response Code (código de resposta rápida)
RDC	Resolução da Diretoria Colegiada
TCLE	Termo de Consentimento Livre e Esclarecido
UNIOESTE	Universidade Estadual do Oeste do Paraná
WHA	World Health Assembly
WHO	World Health Organization

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO	1
2. PROBLEMATIZAÇÃO	5
3. JUSTIFICATIVA.....	6
4. OBJETIVOS.....	8
4.1. Objetivo Geral.....	8
4.2. Objetivos Específicos.....	8
5. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA	9
6. ASPECTOS METODOLÓGICOS	12
6.1. Caracterização do estudo	12
6.2. Local e população do estudo	12
6.3. Critérios de inclusão e exclusão	12
6.4. Instrumento de coleta de dados.....	13
6.5. Validação do instrumento	14
6.6. Procedimento de coleta de dados.....	15
6.7. Análise dos dados.....	16
6.7. Aspectos éticos.....	17
7. RESULTADOS.....	18
8. DISCUSSÃO	24
CONSIDERAÇÕES FINAIS	28
REFERÊNCIAS.....	30
APÊNDICES	34
ANEXOS	44

1. INTRODUÇÃO

O serviço de saúde pode ser compreendido como um conjunto de estabelecimentos destinados à prestação de assistência à população, abrangendo ações de prevenção, diagnóstico, tratamento, recuperação e reabilitação em diferentes níveis de atenção e cenários assistenciais, como hospitais, clínicas, ambulatórios e unidades de atenção básica (Brasil, 2011). Nesse contexto, a segurança do paciente configura-se como um dos pilares fundamentais da qualidade do cuidado em saúde, sendo definida como a redução do risco de danos evitáveis associados à assistência a níveis considerados aceitáveis, considerando o conhecimento científico disponível, os recursos existentes e o contexto assistencial (World Health Organization, 2023).

A preocupação com os danos decorrentes do cuidado em saúde, embora amplamente discutida na contemporaneidade, possui raízes históricas antigas. Desde a Antiguidade, Hipócrates já alertava para a possibilidade de que intervenções terapêuticas pudessem produzir efeitos indesejáveis, estabelecendo o princípio ético *primum non nocere*, isto é, “primeiro, não causar danos”. Posteriormente, no século XIX, Florence Nightingale reforçou essa perspectiva ao afirmar que a principal exigência de um hospital deveria ser evitar que o paciente fosse prejudicado pela assistência prestada (World Health Organization, 2022). Tais princípios permanecem atuais diante da crescente complexidade dos sistemas de saúde e dos múltiplos processos envolvidos no cuidado contemporâneo.

A discussão moderna sobre segurança do paciente ganhou maior visibilidade internacional a partir da publicação do relatório *To Err is Human*, que evidenciou a magnitude dos eventos adversos nos serviços de saúde e impulsionou a adoção de políticas voltadas à prevenção de danos (Institute of Medicine, 1999). A partir desse marco, organismos internacionais passaram a enfatizar a necessidade de estratégias sistemáticas para redução de riscos e fortalecimento da cultura de segurança nas instituições de saúde (Panagioti et al., 2022).

Os riscos presentes no cuidado em saúde podem resultar em eventos adversos, definidos como danos não intencionais decorrentes das intervenções realizadas nos pacientes e que não estão relacionados ao curso natural da doença preexistente. Estudos recentes apontam que uma proporção significativa desses eventos é potencialmente evitável, evidenciando a importância da implementação de práticas seguras e da melhoria contínua dos processos assistenciais (Rodziewicz; Houseman; Hipskind, 2024).

Quando o incidente resulta em prejuízo à saúde do indivíduo, configurando qualquer efeito deletério decorrente da assistência prestada, este é denominado evento adverso. Esses eventos podem ser classificados como evitáveis ou não evitáveis e frequentemente estão associados a falhas em processos organizacionais, comunicação inadequada entre profissionais ou limitações estruturais dos sistemas de saúde (World Health Organization, 2023).

Dentre os eventos adversos mais observados nos serviços de saúde destacam-se os erros de medicação, falhas diagnósticas, erros relacionados à lateralidade de procedimentos, infecções relacionadas à assistência à saúde (IRAS) e problemas de comunicação entre profissionais da equipe multiprofissional. Esses eventos resultam da interação complexa entre fatores humanos, tecnológicos, organizacionais e ambientais presentes nos sistemas de cuidado (World Health Organization, 2024). A literatura contemporânea aponta que tais eventos raramente decorrem exclusivamente de falhas individuais, sendo frequentemente consequência de vulnerabilidades sistêmicas relacionadas às condições de trabalho, aos processos assistenciais e à organização dos serviços de saúde (Vincent; Amalberti, 2023).

Além dos impactos diretos sobre os pacientes, eventos adversos também podem gerar consequências significativas para os profissionais envolvidos no cuidado, fenômeno conhecido como segunda vítima. Profissionais que participam de eventos adversos podem experimentar sofrimento emocional, ansiedade, sentimento de culpa e redução da confiança profissional, evidenciando que a segurança do paciente envolve não apenas a proteção do indivíduo assistido, mas também o cuidado com os profissionais e com o próprio sistema de saúde (Busch et al., 2022).

Nesse cenário, a formação dos profissionais de saúde assume papel central na consolidação de práticas assistenciais seguras. Entretanto, evidências recentes indicam que o ensino da segurança do paciente nos cursos da área da saúde ainda ocorre frequentemente de maneira fragmentada e pouco integrada ao currículo, o que pode dificultar o desenvolvimento de competências essenciais para a identificação e prevenção de riscos no cuidado (Nora et al., 2022; Okuyama; Wagner; Bijnen, 2023). Essa fragmentação curricular pode tornar complexa a própria avaliação da percepção dos estudantes sobre segurança do paciente, uma vez que o contato com o tema ocorre em diferentes disciplinas e momentos formativos, nem sempre de forma articulada.

Para reduzir os riscos de eventos adversos, recomenda-se que a segurança do paciente seja incorporada de forma transversal ao longo da formação dos profissionais de saúde, possibilitando o desenvolvimento progressivo de competências relacionadas à comunicação segura, ao trabalho em equipe e à gestão de riscos assistenciais (World Health Organization, 2023). No Brasil, iniciativas institucionais e políticas públicas também reforçam a importância de inserir essa temática nos currículos da área da saúde, com o objetivo de fortalecer a cultura de segurança nos serviços de saúde (Brasil, 2013).

Entretanto, a incorporação efetiva da segurança do paciente nos processos formativos ainda apresenta desafios nas instituições de ensino superior. Muitas vezes, o tema é abordado de forma pontual ou associado a conteúdos específicos, o que pode limitar a compreensão dos estudantes sobre sua relevância na prática clínica e dificultar a construção de uma cultura de segurança consistente (Adamy et al., 2023).

No curso de graduação em Enfermagem, essa questão torna-se particularmente relevante em função da inserção dos estudantes em cenários assistenciais durante a formação. Conforme as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Enfermagem, os estudantes devem realizar estágios supervisionados em diferentes níveis de atenção à saúde, incluindo hospitais, ambulatórios e serviços da atenção básica (Brasil, 2001). A revisão recente dessas diretrizes prevê a ampliação da carga horária destinada aos estágios curriculares, reforçando a importância da integração entre teoria e prática no processo formativo (Brasil, 2024).

A inserção dos estudantes em cenários reais de cuidado os expõe a diferentes situações relacionadas à segurança do paciente, incluindo falhas assistenciais, limitações organizacionais e desafios no processo de comunicação entre profissionais de saúde. Essas experiências contribuem para a construção da percepção dos estudantes acerca da segurança do paciente e evidenciam a necessidade de estratégias pedagógicas capazes de integrar teoria, prática e reflexão crítica durante a formação profissional (Granadeiro et al., 2025).

Apesar da crescente relevância da segurança do paciente no contexto das políticas públicas e da educação em saúde, ainda persistem lacunas importantes no conhecimento acerca de como estudantes de enfermagem compreendem e internalizam esse conceito ao longo de sua formação acadêmica. Embora diretrizes curriculares e iniciativas institucionais recomendem a incorporação do tema nos cursos da área da saúde, evidências da literatura indicam que sua abordagem frequentemente ocorre de forma fragmentada, pontual ou diluída entre diferentes disciplinas, o que pode dificultar a consolidação de competências relacionadas à prevenção de incidentes e à promoção de práticas assistenciais seguras (Firat Kılıç; Cevheroğlu, 2023).

Além disso, a segurança do paciente constitui um conceito multidimensional, que envolve aspectos técnicos, organizacionais, éticos e relacionais do cuidado em saúde. Essa complexidade conceitual, associada à diversidade de cenários de aprendizagem e às diferentes estratégias pedagógicas adotadas pelas instituições de ensino, torna particularmente desafiador compreender de que maneira os estudantes percebem, interpretam e incorporam esse tema durante o processo formativo (Ghasempour et al. 2023).

Nesse contexto, torna-se necessário aprofundar a investigação sobre como a segurança do paciente é percebida pelos estudantes de enfermagem e de que forma essa temática tem sido efetivamente integrada às experiências de ensino e prática clínica ao longo da graduação, uma vez que essa compreensão pode subsidiar o aprimoramento das estratégias pedagógicas e contribuir para o fortalecimento da cultura de segurança na formação dos futuros profissionais de saúde.

2. PROBLEMATIZAÇÃO

A forma como estudantes de enfermagem compreendem a segurança do paciente durante a graduação pode influenciar diretamente a maneira como irão reconhecer riscos, tomar decisões clínicas e atuar na prevenção de eventos adversos ao longo da vida profissional. Nesse sentido, a formação acadêmica desempenha papel fundamental no desenvolvimento de competências relacionadas à cultura de segurança e à qualidade da assistência em saúde (Panagioti et al., 2022).

Entretanto, a incorporação efetiva da segurança do paciente no processo formativo ainda representa um desafio para muitas instituições de ensino. Embora políticas internacionais e nacionais incentivem a inclusão do tema nos currículos da área da saúde, evidências apontam que sua abordagem frequentemente ocorre de maneira pontual ou associada a conteúdos específicos, o que pode limitar a compreensão dos estudantes sobre a natureza sistêmica dos eventos adversos e sobre a complexidade dos processos assistenciais (World Health Organization, 2024).

Além disso, quando o ensino da segurança do paciente não está articulado às experiências práticas vivenciadas nos cenários de cuidado, os estudantes podem apresentar dificuldades em reconhecer fatores de risco, interpretar situações críticas e aplicar estratégias preventivas durante a prática clínica. Nesse contexto, compreende-se que a forma como essa temática é abordada ao longo da formação pode influenciar não apenas o conhecimento teórico adquirido, mas também a capacidade dos futuros profissionais de integrar princípios de segurança à prática assistencial cotidiana.

3. JUSTIFICATIVA

Evidências recentes demonstram que, apesar dos avanços regulatórios e das iniciativas internacionais voltadas à promoção da segurança do paciente, os danos evitáveis continuam representando um importante problema de saúde pública em escala global. Estima-se que milhões de pacientes sofram eventos adversos relacionados à assistência em saúde a cada ano, muitos deles potencialmente evitáveis, o que evidencia fragilidades nos processos assistenciais e na formação dos profissionais envolvidos no cuidado (Slawomirski; Auraaen; Klazinga, 2023). Além do impacto direto na morbimortalidade, o cuidado inseguro gera consequências econômicas relevantes, aumentando o tempo de internação, os custos hospitalares e a sobrecarga dos sistemas de saúde.

No Brasil, a segurança do paciente passou a ocupar posição estratégica nas políticas públicas de saúde a partir da implementação de marcos regulatórios que incentivam a adoção de práticas seguras nos serviços de saúde. A Resolução da Diretoria Colegiada nº 36/2013 estabeleceu a obrigatoriedade da implantação dos Núcleos de Segurança do Paciente (NSP) nas instituições de saúde, bem como a notificação sistemática de incidentes ao Sistema de Notificações em Vigilância Sanitária (NOTIVISA), fortalecendo o papel da vigilância sanitária na identificação, monitoramento e prevenção de eventos adversos (Brasil, 2013). Dados nacionais demonstram que centenas de milhares de incidentes relacionados à assistência vêm sendo registrados ao longo dos últimos anos, revelando não apenas a magnitude do problema, mas também desigualdades regionais na capacidade de vigilância, registro e análise desses eventos nos serviços de saúde (Agência Nacional de Vigilância Sanitária, 2022).

Diante desse cenário, a formação dos profissionais de saúde emerge como um componente essencial para o fortalecimento da cultura de segurança nas organizações assistenciais. Estudos recentes apontam que a inclusão sistemática da segurança do paciente nos currículos da área da saúde contribui para o desenvolvimento de competências relacionadas à gestão de riscos, comunicação em equipe e tomada de decisão clínica segura (Tella; Smith; O'Connor, 2022). No campo da Enfermagem, essa discussão torna-se particularmente relevante, considerando que esses profissionais desempenham papel central na coordenação do cuidado, na administração de terapias e na vigilância contínua do paciente.

Nesse contexto, as diretrizes educacionais brasileiras também reforçam a necessidade de incorporar princípios de qualidade e segurança na formação em saúde. Documentos orientadores da educação em enfermagem destacam que o processo formativo deve desenvolver competências técnicas, éticas e científicas capazes de sustentar práticas assistenciais seguras e centradas no paciente (Brasil, 2018). No entanto, a efetiva integração desses princípios ao processo formativo ainda enfrenta desafios relacionados à organização curricular, às estratégias pedagógicas e à articulação entre ensino e prática clínica.

Assim, compreender como estudantes de enfermagem percebem a segurança do paciente durante sua formação acadêmica torna-se relevante para identificar possíveis fragilidades no processo de ensino-aprendizagem e para subsidiar estratégias educacionais capazes de fortalecer a cultura de segurança nos serviços de saúde. Investigar essa percepção pode contribuir para alinhar a formação profissional às demandas contemporâneas dos sistemas de saúde, promovendo a construção de profissionais mais preparados para atuar de maneira crítica, responsável e segura nos diferentes cenários assistenciais.

Diante dessas considerações, este estudo busca responder à seguinte questão de pesquisa: “Qual é a percepção dos acadêmicos de Enfermagem acerca da segurança do paciente no contexto de sua formação?”

4. OBJETIVOS

4.1. Objetivo Geral

Compreender a percepção do acadêmico de Enfermagem acerca da segurança do paciente no contexto de seu processo formativo.

4.2. Objetivos Específicos

Considerando que a percepção dos acadêmicos será investigada por meio de um instrumento estruturado, cujos itens contemplam diferentes dimensões da temática da segurança do paciente, os objetivos específicos deste estudo são operacionalizados a partir dos domínios investigados pelo instrumento de coleta de dados, sendo eles:

- Avaliar o entendimento dos acadêmicos de enfermagem sobre o significado de segurança do paciente – Domínio 1: Conhecimento sobre Segurança do Paciente;
- Verificar se a temática da segurança do paciente é abordada pelos professores durante o processo de ensino-aprendizagem- Domínio 2: Abordagem no Processo de Ensino-Aprendizagem;
- Analisar se os acadêmicos de enfermagem aplicam os conhecimentos sobre segurança do paciente nos estágios supervisionados e em suas atividades práticas – Domínio 3: Aplicação Prática e Atitudes;
- Analisar se os acadêmicos de enfermagem reconhecem a importância da comunicação efetiva e da identificação precoce de erros, como estratégias essenciais para promover um cuidado mais seguro e prevenir eventos adversos – Domínio 4: Cultura de Segurança, feedback e melhoria contínua.

5. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

A segurança do paciente ganhou destaque no cenário internacional a partir de 1999, com a publicação do relatório *To Err is Human*, elaborado pelo Institute of Medicine, dos Estados Unidos. O documento evidenciou que aproximadamente 98 mil mortes anuais ocorriam em hospitais norte-americanos em decorrência de falhas evitáveis, incluindo erros na administração de medicamentos, infecções relacionadas à assistência à saúde e complicações cirúrgicas. A divulgação desses dados impulsionou o desenvolvimento de iniciativas voltadas à segurança do paciente, estimulando a criação de programas e estratégias destinadas à melhoria da qualidade e da segurança no ambiente hospitalar (Institute of Medicine, 1999).

No contexto brasileiro, a instituição do Programa Nacional de Segurança do Paciente (PNSP), em 2013, representou um importante avanço na incorporação de diretrizes voltadas à segurança nas unidades de saúde. Entre as principais ações do programa destacam-se a elaboração de protocolos específicos para a prevenção de infecções relacionadas à assistência à saúde e a redução de erros na administração de medicamentos (Brasil, 2013). Tais diretrizes têm como objetivo consolidar a segurança do paciente como uma prática cotidiana, reconhecida e valorizada por todos os profissionais envolvidos no cuidado.

De acordo com o Ministério da Saúde, o PNSP “visa promover a qualificação contínua dos profissionais e melhorar as práticas assistenciais” (Brasil, 2013). Dessa forma, busca-se integrar a segurança do paciente ao cotidiano dos serviços de saúde, reafirmando-a como um compromisso coletivo e permanente.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) define a segurança do paciente como a “redução, a um mínimo aceitável, do risco de danos desnecessários associados ao cuidado em saúde”. Esse conceito reforça a necessidade de investir na capacitação dos profissionais, de modo a promover práticas assistenciais mais seguras e qualificadas (OMS, 2009).

Nesse sentido, as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) estabelecem que a formação em Enfermagem deve desenvolver competências relacionadas à segurança, à qualidade e à humanização do cuidado (Brasil, 2018). Contudo, assegurar que esses princípios sejam efetivamente incorporados pelos estudantes ao longo do processo formativo ainda constitui um desafio significativo.

A percepção pode ser entendida como o "ato ou efeito de perceber; capacidade de apreender algo por meio dos sentidos ou da mente; conhecimento ou consciência que se tem de algo" (Aurélio, 2023).

Na enfermagem, a percepção dos estudantes sobre a segurança do paciente está diretamente relacionada à maneira como os currículos abordam esse tema. Um dos principais obstáculos é a fragmentação dos conteúdos sobre segurança do paciente. Mesmo que a DCN trate a segurança como prioridade, muitas vezes o tema é tratado de forma isolada, sem a integração com outras práticas de cuidado (Bohomol, 2019).

A construção do conhecimento em segurança do paciente deve ser contínua e acompanhada pelas mudanças sociais e históricas do cuidado.

Segundo Freire (1980, p. 39), já relatava que:

“É preciso que a educação esteja - em seu conteúdo, em seus programas e em seus métodos - adaptada ao fim que se persegue: permitir ao homem chegar a ser sujeito, construir-se como pessoa, transformar o mundo, estabelecer com os outros homens relações de reciprocidade, fazer a cultura e a história” (FREIRE, 1980, p. 39).

A formação de uma cultura de segurança desde o período acadêmico também se mostra essencial. De acordo com Alves et al. (2021), “acadêmicos com uma base sólida em segurança do paciente tendem a adotar práticas preventivas durante o exercício profissional” (Alves et al., 2021, p. 839). Esse aspecto cultural contribui para que o estudante desenvolva uma visão crítica e esteja preparado para identificar e relatar falhas sem receio de represálias. Essa postura é fundamental para criar um ambiente de aprendizado e melhoria contínua, onde o erro é visto como uma oportunidade de aperfeiçoamento.

Entretanto, adotar uma cultura de segurança vai além da simples adoção de protocolos; ela exige o engajamento de todos os profissionais de saúde e dos estudantes. Como sugere Bohomol (2019), o ensino da segurança deve ser uma prioridade desde o início do curso.

Segundo a OMS, a cultura de segurança é o conjunto de valores, comportamentos e atitudes que determinam o compromisso de uma organização com

a segurança de seus pacientes (OMS, 2011). A cultura de segurança não só previne erros, mas promove um ambiente mais seguro para os profissionais e pacientes.

Outro desafio é a utilização de metodologias ativas. Embora a DCN recomende o uso de estratégias pedagógicas que promovam o protagonismo dos estudantes e a aprendizagem baseada em problemas, facilitando a aplicação prática dos conteúdos (Brasil, 2018). No entanto, muitas instituições ainda preferem os métodos tradicionais de ensino, o que acaba limitando a prática de simulações realísticas e estudos de caso, que são essenciais para aprimorar a capacidade crítica dos estudantes. Conforme Sanchis et al. (2020) observam, "o uso de simulações clínicas é fundamental para que os estudantes compreendam os riscos reais e possam desenvolver habilidades para evitá-los".

Promover um ambiente de aprendizado sem punição é essencial para que os estudantes se sintam confortáveis em relatar erros durante o estágio. Alves et al. (2021) afirmam que "ambientes educacionais que incentivam a notificação de erros criam uma cultura de aprendizado contínuo, onde os acadêmicos se sentem encorajados a reconhecer falhas e buscar melhorias", essa cultura desde a formação ajuda os estudantes a compreenderem que a segurança do paciente é uma responsabilidade compartilhada, essencial para o crescimento e a qualidade dos cuidados, no entanto, esse é um caminho desafiador, mas essencial para os futuros profissionais.

6. ASPECTOS METODOLÓGICOS

6.1. Caracterização do estudo

Trata-se de um estudo observacional, transversal, de abordagem quantitativa e caráter descritivo-analítico. Estudos transversais são utilizados para examinar a distribuição de variáveis em uma população em um determinado momento, permitindo descrever fenômenos e explorar possíveis associações entre variáveis (Hulley et al., 2013). Esse tipo de delineamento é amplamente empregado em pesquisas na área da saúde para investigar percepções, conhecimentos e atitudes de profissionais ou estudantes, contribuindo para a identificação de lacunas formativas e necessidades educacionais (Setia, 2022).

O relato metodológico foi organizado de acordo com as recomendações da Strengthening the Reporting of Observational Studies in Epidemiology (STROBE), que orienta a transparência e a qualidade do relato de estudos observacionais (von Elm et al., 2023).

6.2. Local e população do estudo

O estudo foi realizado na Universidade Estadual do Oeste do Paraná, no Curso de Graduação em Enfermagem do Campus de Foz do Iguaçu, Paraná, Brasil.

O curso foi implantado em 1998 e possui duração de cinco anos, oferecendo formação em bacharelado e licenciatura. A proposta pedagógica contempla a formação de profissionais comprometidos com a promoção da saúde integral, a assistência de enfermagem e a atuação em diferentes níveis de atenção à saúde.

A população-alvo foi composta por estudantes regularmente matriculados no 3º, 4º e 5º anos do curso de graduação em enfermagem, por serem etapas da formação em que os acadêmicos já apresentam maior inserção em atividades práticas e estágios supervisionados.

6.3. Critérios de inclusão e exclusão

Foram considerados elegíveis para participação no estudo estudantes regularmente matriculados no 3º, 4º ou 5º ano do curso de Enfermagem.

Os acadêmicos que não estavam presentes no momento da coleta de dados; encontravam-se afastados das atividades acadêmicas por motivos de saúde ou

administrativos ou enfrentaram qualquer circunstância que dificultasse sua participação voluntária no momento da aplicação do instrumento, foram excluídos.

6.4. Instrumento de coleta de dados

O instrumento de coleta de dados foi desenvolvido especificamente para este estudo com o objetivo de avaliar a percepção de acadêmicos de enfermagem acerca da segurança do paciente. O questionário encontra-se disponível no Apêndice I.

O instrumento foi estruturado em duas seções. A primeira refere-se à caracterização sociodemográfica dos participantes, incluindo as variáveis gênero, idade e ano do curso. Essas informações permitiram descrever o perfil dos estudantes e possibilitar análises comparativas entre diferentes grupos da amostra.

A segunda seção foi composta por itens relacionados à percepção dos estudantes sobre segurança do paciente, organizados em quatro domínios conceituais, elaborados a partir da literatura sobre educação em segurança do paciente. O primeiro domínio, denominado conhecimento, buscou investigar o entendimento teórico dos acadêmicos acerca dos princípios e fundamentos da segurança do paciente. O segundo domínio, ensino-aprendizagem, avaliou como a temática é abordada nas disciplinas teóricas e nas atividades acadêmicas do curso. O terceiro domínio, aplicação prática e atitudes, examinou de que maneira os estudantes aplicam os conceitos de segurança do paciente durante os estágios supervisionados e atividades práticas. Por fim, o quarto domínio, cultura de segurança, feedback e melhoria contínua, investigou a percepção dos acadêmicos sobre a importância da comunicação de erros, do aprendizado organizacional e da participação em discussões sobre eventos adversos.

As respostas aos itens do questionário foram registradas por meio de escala Likert de cinco pontos, variando de 1 a 5, sendo: 1 – Discordo totalmente; 2 – Discordo; 3 – Neutro; 4 – Concordo; e 5 – Concordo totalmente. A utilização de escalas do tipo Likert é amplamente recomendada em pesquisas que investigam percepções, atitudes e opiniões, pois permite quantificar avaliações subjetivas e facilita a realização de análises estatísticas comparativas (Boateng et al., 2023).

6.5. Validação do instrumento

O questionário foi submetido a um processo de validação de conteúdo por especialistas, com o objetivo de avaliar a clareza, relevância e adequação dos itens em relação aos objetivos da pesquisa.

O painel de especialistas foi composto por cinco profissionais da área da saúde, sendo três enfermeiros, um farmacêutico e um biomédico. Todos possuíam experiência profissional relacionada à segurança do paciente, gestão da qualidade em saúde ou processos de acreditação hospitalar, o que contribuiu para uma avaliação qualificada do instrumento.

Cada especialista recebeu o questionário por meio eletrônico, acompanhado de orientações sobre os critérios de avaliação. Solicitou-se que cada avaliador analisasse a capacidade do questionário em contemplar adequadamente os objetivos propostos, atribuindo pontuação por meio de uma escala Likert de cinco pontos, assim definida: (1) discordo totalmente – o questionário não aborda suficientemente o objetivo específico; (2) discordo – o questionário aborda parcialmente o objetivo específico, porém de forma insatisfatória; (3) neutro – o questionário pode atender ao objetivo específico, porém necessita de melhorias; (4) concordo – o questionário aborda adequadamente o objetivo específico, com pequenas melhorias a considerar; e (5) concordo totalmente – o questionário atende plenamente ao objetivo específico.

Além da atribuição de pontuação, os especialistas puderam registrar comentários e sugestões com o intuito de aprimorar a redação e a adequação conceitual dos itens. De modo geral, o instrumento foi considerado adequado pelos avaliadores, obtendo predominância de respostas classificadas como “concordo” e “concordo totalmente” nos diferentes objetivos específicos analisados

As sugestões apresentadas pelos especialistas resultaram em ajustes pontuais no instrumento. Na seção referente ao conhecimento sobre segurança do paciente, foi apontada a possibilidade de redundância entre questões que abordavam a definição do conceito de segurança do paciente. Dessa forma, procedeu-se à revisão da redação dos itens, com o objetivo de reduzir possíveis ambiguidades e tornar mais clara a distinção entre a compreensão conceitual geral e o reconhecimento da definição proposta pela Organização Mundial da Saúde.

Na seção relacionada ao processo de ensino-aprendizagem, foi sugerida atenção à formulação de perguntas que abordavam a temática “ao longo do curso”, considerando que estudantes em fases iniciais da formação poderiam ainda não ter

vivenciado plenamente todas as experiências acadêmicas mencionadas. Assim, foram realizados ajustes na redação das questões, buscando torná-las mais adequadas à diversidade de estágios da formação acadêmica.

Adicionalmente, na seção referente à cultura de segurança e ao relato de erros, foi sugerida a revisão da terminologia utilizada na questão que abordava os sistemas de relato de eventos adversos, a fim de evitar interpretações ambíguas quanto ao tipo de sistema referido (institucional, educacional ou relacionado à notificação de incidentes). A redação da questão foi ajustada para tornar o enunciado mais claro e compreensível aos participantes.

Após a incorporação das sugestões apresentadas pelos especialistas, obteve-se a versão final do questionário, considerada adequada para aplicação na população-alvo. A utilização de painéis de especialistas associada ao cálculo do índice de validade de conteúdo constitui procedimento amplamente recomendado para avaliação da qualidade de instrumentos utilizados em pesquisas na área da saúde (Zamanzadeh et al., 2022).

6.6. Procedimento de coleta de dados

A coleta de dados foi realizada por meio de questionário eletrônico disponibilizado na plataforma Google Forms. Para facilitar o acesso ao instrumento pelos participantes, foi gerado um QR Code, o qual foi apresentado aos estudantes durante as atividades em sala de aula, conforme o calendário acadêmico da instituição.

Antes da aplicação do questionário, os participantes receberam informações sobre os objetivos da pesquisa, bem como sobre os procedimentos envolvidos no estudo. Em seguida, foi apresentado o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), garantindo que os estudantes compreendessem as condições de participação e tivessem liberdade para decidir sobre sua adesão ao estudo.

A aplicação do instrumento ocorreu em ambiente de sala de aula, considerado adequado por permitir maior controle do ambiente de coleta, possibilidade de esclarecimento de dúvidas e garantia de participação voluntária dos estudantes. O tempo médio necessário para o preenchimento do questionário foi de aproximadamente 8 a 10 minutos.

6.7. Análise dos dados

Os dados foram analisados quantitativamente por meio do software R (R Core Team, 2025). Inicialmente foi realizada análise descritiva da amostra, com cálculo de frequências absolutas e relativas para variáveis categóricas, além de medidas de tendência central e dispersão para os escores obtidos nos domínios do questionário.

Para cada domínio do instrumento foi calculado um escore composto, obtido pela soma das respostas Likert dos itens correspondentes. Esse procedimento permitiu mensurar a percepção dos estudantes em relação às diferentes dimensões investigadas: conhecimento sobre segurança do paciente, abordagem da temática no processo de ensino-aprendizagem, aplicação prática dos conhecimentos em atividades clínicas e percepção sobre cultura de segurança, feedback e melhoria contínua.

Com o objetivo de analisar a correspondência entre a percepção dos estudantes e o currículo formal do curso, foi realizada análise documental da matriz curricular do curso de enfermagem. Esse procedimento ocorreu em três etapas: identificação das disciplinas que abordam conteúdos relacionados à segurança do paciente; análise das ementas e conteúdos programáticos dessas disciplinas; e comparação entre os conteúdos previstos na matriz curricular e as percepções relatadas pelos estudantes nos domínios ensino-aprendizagem e cultura de segurança. Essa análise permitiu identificar possíveis discrepâncias entre o conteúdo formalmente previsto no currículo e a percepção dos estudantes sobre a abordagem da temática durante sua formação.

Para a análise comparativa entre grupos sociodemográficos, como gênero, faixa etária e ano do curso, foram utilizados testes estatísticos não paramétricos, considerando o tamanho reduzido da amostra e a natureza ordinal das variáveis obtidas por escala Likert. Foram aplicados o teste de Wilcoxon para comparação entre dois grupos e o teste de Kruskal-Wallis para comparação entre três ou mais grupos.

Posteriormente foi ajustado um modelo de regressão linear múltiplo, considerando como variável dependente o escore total de percepção obtido a partir da soma das respostas Likert de todos os itens do questionário. As variáveis independentes incluídas no modelo foram gênero, faixa etária e ano do curso. O nível de significância adotado para os testes estatísticos foi de $\alpha < 0,05$.

6.7. Aspectos éticos

O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, sob parecer nº 7.610.530. A pesquisa seguiu os princípios éticos estabelecidos pela Resolução CNS nº 466/2012, que regulamenta pesquisas envolvendo seres humanos no Brasil.

Todos os participantes foram informados sobre os objetivos do estudo, os procedimentos de coleta de dados e os possíveis riscos e benefícios da pesquisa. A participação foi voluntária e condicionada à assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Foi garantido o anonimato dos participantes e a confidencialidade das informações coletadas.

7. RESULTADOS

Foram obtidas 39 respostas válidas, provenientes de um total de 71 acadêmicos regularmente matriculados no curso, correspondendo a uma taxa de participação de 54,9%.

Entre os participantes do estudo, 76,92% são do sexo feminino, enquanto 23,08% são do sexo masculino, e dividem-se em 46,15% entre 18 a 21 anos, 41,03% de 22 a 25 anos, 5,13% de 26 a 29 anos e 7,69% de 30 anos ou mais. Os estudantes estão matriculados no 3º, 4º e 5º ano do curso, sendo 43,59% no 3º ano, 43,59% no 4º ano e 12,82% no 5º ano (Tabela 1).

As medidas-resumo com base na escala Likert de cada item mostra que diversas questões apresentaram pelo menos uma resposta de nível mínimo (1 - Discordo totalmente), mas que, por outro lado, quase todas obtiveram ao menos uma resposta máxima (5 - Concordo totalmente), com exceção do item “1.4 - Profissionais de saúde comprometidos com seu trabalho não cometem erros durante a prestação de cuidado”. Grande parte dos itens apresentaram uma média acima de 3,5, com exceção do item “3.3 - O ambiente de estágio oferece condições adequadas para a promoção da segurança do paciente”, que apresentou média de 3,00.

O resultado das respostas ao item “1.4 - Profissionais de saúde comprometidos com seu trabalho não cometem erros durante a prestação de cuidado”, que apresentou média de 2,26, demonstrou que os alunos possuem discernimento de que, mesmo com alto grau de comprometimento e atenção, o profissional é passível de cometer erros no exercício de sua função. A maioria dos estudantes (56,4%) entrevistados cursam os últimos anos do curso e também observa-se que a vivência em ambientes de trabalho possa contribuir para resposta negativa quanto à oferta de condições para prática de segurança do paciente, uma vez que se observa registro de respostas nos extremos da escala (1 e 5) e a média pode ser considerada ambivalente. O item com maior média foi o “2.2 - A discussão sobre erros em sala de aula ou durante o estágio é importante para melhorar minha prática”, obtendo um valor de 4,67, indicando que os estudantes reconhecem a importância de discussões sobre incidentes para a prática e formação profissional. A abordagem do tema ao longo do curso, avaliado no item 2.1 do questionário, apresenta uma média de repostas indicando que a maioria dos alunos concorda que a segurança do paciente é um tema abordado de forma recorrente na grade curricular. No entanto, considerando o desvio

padrão, pode-se dizer que a percepção sobre o assunto pode ser ambivalente entre “neutro” e “concordo” (Tabela 2).

Tabela 1. Caracterização sociodemográfica dos estudantes de enfermagem, Foz do Iguaçu, Paraná, 2025.

Variável	Níveis	(N)	(%)
Gênero	Feminino	30	76,92%
	Masculino	9	23,08%
Faixa etária	18 a 21 anos	18	46,15%
	22 a 25 anos	16	41,03%
	26 a 29 anos	2	5,13%
	30 anos ou mais	3	7,69%
	3º ano	17	43,59%
Ano do curso que você está matriculado	4º ano	17	43,59%
	5º ano	5	12,82%

Tabela 2. Medidas-resumo da escala Likert por item e por domínio, de acordo com as respostas dos estudantes de enfermagem, Foz do Iguaçu, Paraná, 2025.

Variável	Média	Desvio-Padrão	Mínimo	Máximo
1.1. A segurança do paciente pode ser definida como a eliminação total dos riscos que possam evoluir para um evento adverso durante a assistência à saúde	3.85	0.87	1.00	5.00
1.2. Eu compreendo o conceito de segurança do paciente e sua importância para o trabalho da equipe de enfermagem	4.26	0.55	3.00	5.00
1.3. A segurança do paciente refere-se à redução dos riscos de danos desnecessários, ao mínimo aceitável relacionado à assistência de saúde	4.18	0.88	1.00	5.00
1.4. Profissionais de saúde comprometidos com seu trabalho não cometem erros durante a prestação de cuidado	2.26	0.88	1.00	4.00
GERAL DOMÍNIO 1	3.63	0.80	1.50	4.75

2.1. A segurança do paciente foi um tema recorrente nas aulas teóricas ao longo do curso	3.82	0.82	2.00	5.00
2.2. A discussão sobre erros em sala de aula ou durante o estágio é importante para melhorar minha prática	4.67	0.48	4.00	5.00
2.3. As atividades e simulação realística realizadas durante o curso, abordam os aspectos de segurança do paciente	3.92	0.96	1.00	5.00
GERAL DOMÍNIO 2	4.14	0.75	2.33	5.00
3.1. Eu aplico corretamente as medidas de segurança do paciente durante os estágios	4.00	0.61	3.00	5.00
3.2. Os professores de estágio reforçaram a importância da segurança do paciente durante as atividades práticas	4.21	0.52	3.00	5.00
3.3. O ambiente de estágio oferece condições adequadas para a promoção da segurança do paciente	3.00	1.03	1.00	5.00
GERAL DOMÍNIO 3	3.74	0.72	2.33	5.00
4.1. Considero que os sistemas de notificações de eventos/erros contribuem para a prevenção de novos eventos/erros	4.26	0.79	2.00	5.00
4.2. Acredito que todos os profissionais envolvidos devem participar de discussões sobre a ocorrência de eventos adversos	4.51	0.51	4.00	5.00
4.3. Sinto-me confortável em relatar erros que ocorrem durante os estágios aos professores	3.56	1.12	1.00	5.00
4.4. Após identificar um erro, os professores promovem discussões sobre as causas e as melhores estratégias para evitá-lo no futuro	3.62	0.81	1.00	5.00
GERAL DOMÍNIO 4	3.99	0.81	2.00	5.00

A distribuição de frequências (N e %) dos níveis de resposta “Discordo totalmente”, “Discordo”, “Neutro”, “Concordo” e “Concordo totalmente” para cada um dos 14 itens perguntados, encontra-se no Apêndice II.

O *boxplot* dos escores médios de cada domínio mostra que o domínio 3 não apresenta valores discrepantes, embora revele maior dispersão das respostas em comparação aos demais domínios, o que indica maior variabilidade interna dos escores, e não necessariamente a presença de observações extremas. O domínio 2 apresenta uma mediana coincidindo com o 3º quartil, indicando que 50% das respostas são de valores altos na escala (Figura 1).

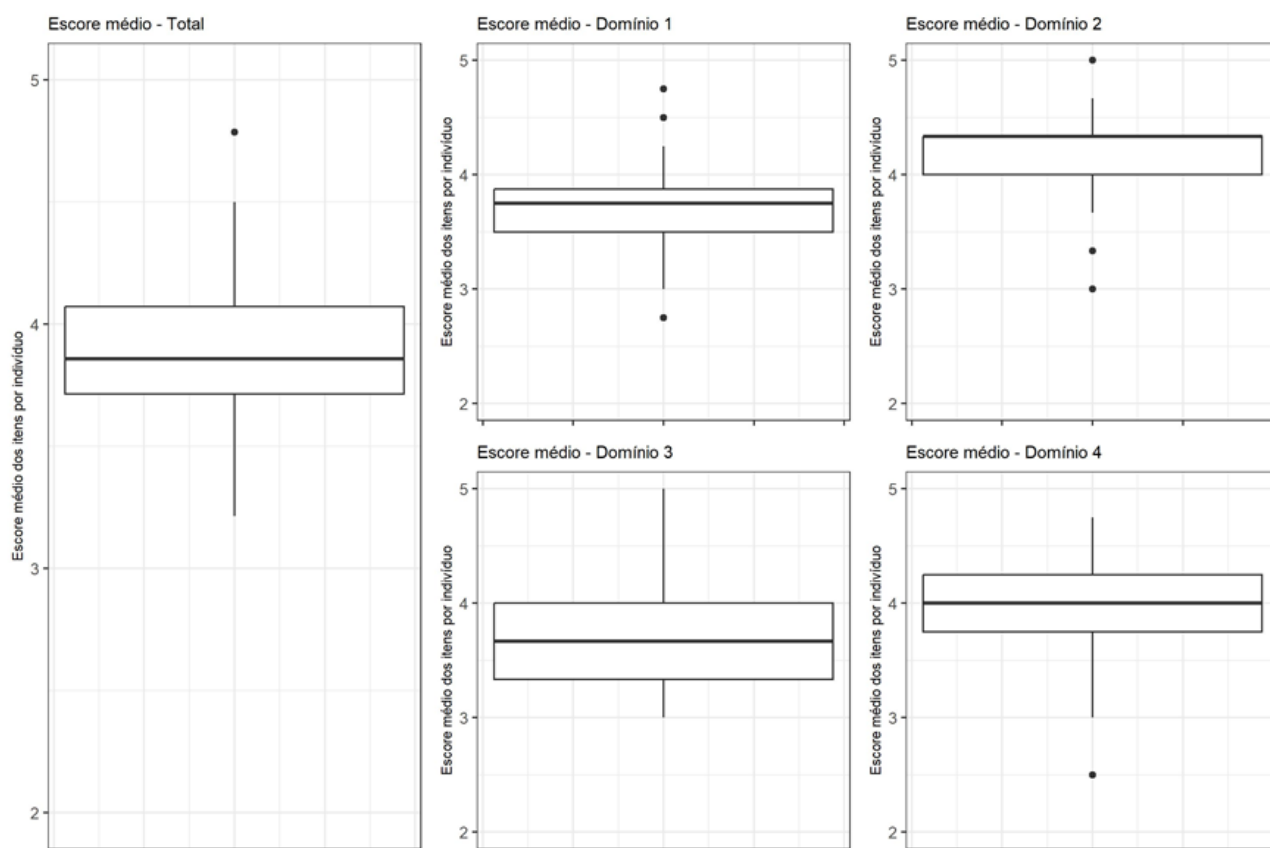


Figura 1: *Boxplot* dos escores médios de cada domínio, com base nas respostas dos estudantes de enfermagem, Foz do Iguaçu, Paraná, 2025.

Os testes de medianas entre grupos não apontaram diferença significativa entre o escore total (soma de todos os itens) e as variáveis sociodemográficas de gênero, faixa etária e ano do curso. Os gráficos *boxplot* corroboram com os achados, uma vez que todos apontam sobreposição das caixas para todas as variáveis testadas. O sexo feminino indica uma variabilidade levemente maior que o sexo

masculino no que diz respeito ao escore total, bem como a faixa etária de 30 anos ou mais, que além de mostrar menor variabilidade, possui uma mediana coincidindo com o 1º quartil, indicando que 50% das respostas desta faixa etária foram mais baixas na escala. A variabilidade entre os anos do curso é relativamente similar, com o 3º ano indicando a presença de um *outlier* (Figura 2).

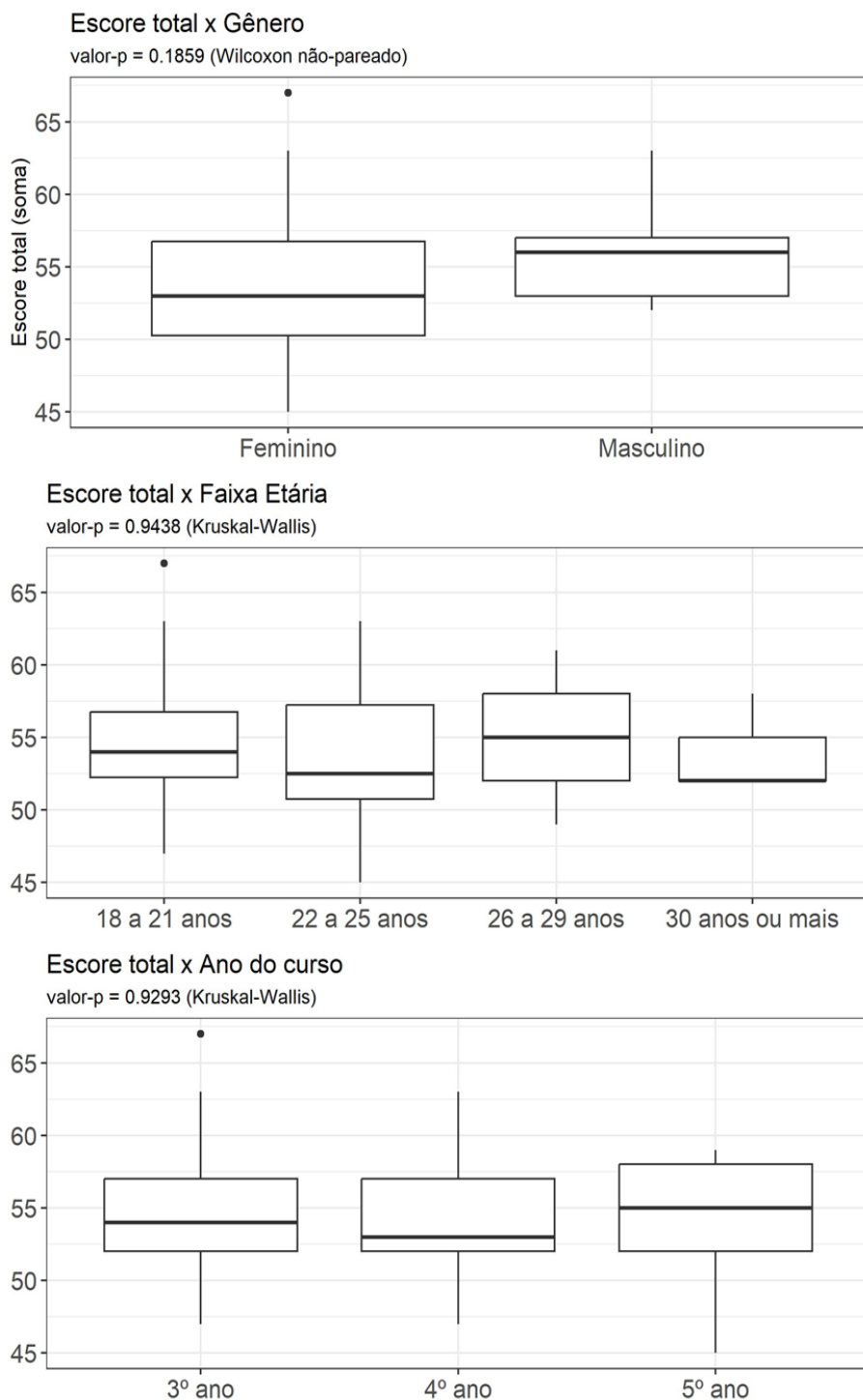


Figura 2. Boxplot dos escores totais entre os fatores sociodemográficos dos estudantes de enfermagem, Foz do Iguaçu, Paraná, 2025.

Para testar a associação dos fatores sociodemográficos de forma conjunta, um modelo de regressão linear múltiplo foi ajustado, considerando como variável resposta o escore total (soma de todos os itens), em função das 3 covariáveis sociodemográficas. O modelo não apontou associação para nenhuma das variáveis em relação ao escore total (Tabela 3).

Tabela 3. Estimativas do modelo de regressão linear múltiplo para a variável resposta “escore total” em função dos fatores sociodemográficos dos estudantes de Enfermagem, Foz do Iguaçu, Paraná, 2025.

Coeficiente	Estimativa	Erro Padrão	Estatística t	Pr(> t)
(Intercepto)	53.78	1.65	32.58	<0.001
Gênero - Masculino	2.35	2.07	1.14	0.2636
Faixa etária - 22 a 25 anos	-1.03	1.87	-0.55	0.5853
Faixa etária - 26 a 29 anos	1.22	3.96	0.31	0.7597
Faixa etária - 30 anos ou mais	-0.69	3.21	-0.22	0.8305
Ano do curso que você está matriculado - 4º ano	0.19	1.92	0.10	0.9197
Ano do curso que você está matriculado - 5º ano	0.84	2.92	0.29	0.7742

8. DISCUSSÃO

A discussão dos achados foi organizada a partir dos domínios do instrumento, em consonância com os objetivos específicos do estudo, buscando interpretar os resultados à luz da literatura recente sobre formação em enfermagem, cultura de segurança e aprendizagem em cenários clínicos. Na amostra analisada, observou-se predomínio de estudantes do sexo feminino e de faixas etárias mais jovens, com maior concentração nos anos intermediários e finais da graduação. Esse perfil é coerente com a composição contemporânea da enfermagem, ainda caracterizada pela predominância feminina em sua força de trabalho e pela maior inserção prática nos anos finais do curso (WHO, 2025).

No primeiro domínio, os resultados sugerem que os acadêmicos apresentam compreensão globalmente satisfatória dos fundamentos da segurança do paciente. O item que apresentou menor média foi aquele que afirmava que profissionais comprometidos não cometem erros durante a assistência, indicando discordância por parte dos participantes. Esse resultado revela que os estudantes reconhecem que o erro não decorre exclusivamente de negligência ou falta de comprometimento individual, mas pode estar associado à complexidade dos sistemas de saúde e às condições de trabalho nos serviços assistenciais. Esse entendimento aproxima-se da perspectiva sistêmica da segurança do paciente, amplamente discutida na literatura contemporânea, segundo a qual falhas assistenciais frequentemente resultam em interações entre fatores humanos, organizacionais e ambientais (Wachter, 2010; Glarcher et al., 2025).

Esse resultado também sugere uma mudança importante de paradigma na formação dos futuros profissionais. A compreensão de que erros podem ocorrer mesmo entre profissionais comprometidos representa um passo relevante para o desenvolvimento de uma cultura de segurança baseada no aprendizado organizacional e na análise sistêmica das falhas, em oposição à tradicional cultura punitiva centrada na culpabilização individual (Gore; Schrems, 2025).

No segundo domínio, os estudantes atribuíram alto valor pedagógico à discussão de erros em sala de aula e nos estágios, especialmente no item que apresentou a maior média do estudo. Esse resultado indica que os participantes reconhecem a discussão de incidentes como estratégia importante para aprimorar a prática clínica e desenvolver pensamento crítico. Estudos recentes demonstram que

intervenções educacionais focadas na segurança do paciente, como análise de casos, simulação clínica e discussão estruturada de eventos adversos, contribuem significativamente para o desenvolvimento de competências relacionadas à gestão de riscos e à tomada de decisão clínica segura (Al-Nawafleh et al., 2024).

Apesar dessa valorização do tema, a percepção sobre a recorrência da segurança do paciente ao longo da formação mostrou-se relativamente heterogênea entre os estudantes. Embora muitos reconheçam que o tema é abordado durante o curso, a dispersão das respostas sugere que essa abordagem pode ocorrer de forma irregular entre disciplinas ou momentos formativos. Esse achado está alinhado com revisões recentes que apontam que o ensino da segurança do paciente na graduação frequentemente ocorre de forma fragmentada, sem progressão pedagógica clara ao longo do currículo (Alrasheeday et al., 2025).

No terceiro domínio, que avaliou a aplicação prática dos conhecimentos de segurança do paciente nos estágios, os resultados indicaram maior variabilidade nas respostas. Embora os estudantes relatem aplicar medidas de segurança durante suas atividades práticas, a percepção sobre as condições dos ambientes de estágio mostrou-se menos favorável. O item referente às condições adequadas para promoção da segurança apresentou média intermediária e respostas distribuídas em diferentes níveis da escala, indicando que a experiência dos estudantes nos cenários clínicos não é homogênea.

Esse resultado pode refletir a conhecida tensão entre o conhecimento teórico adquirido na universidade e as condições reais encontradas nos serviços de saúde. Estudos recentes apontam que fatores como subdimensionamento de pessoal, sobrecarga de trabalho e limitações organizacionais podem influenciar a experiência de aprendizagem dos estudantes e a implementação de práticas seguras nos cenários clínicos (Oshodi et al., 2025).

Outro aspecto relevante é que os estudantes atribuíram avaliação mais positiva ao papel do professor supervisor do que às condições estruturais dos cenários de estágio. Isso sugere que a supervisão docente pode atuar como elemento mediador entre o conhecimento teórico e a prática clínica. Pesquisas recentes indicam que o suporte do supervisor durante os estágios contribui para o desenvolvimento de confiança profissional, reflexão crítica e aprendizagem a partir de eventos relacionados à segurança do paciente (Javornická et al., 2024).

No quarto domínio, que investigou a percepção dos estudantes sobre comunicação e notificação de erros, os resultados indicaram uma percepção globalmente positiva sobre a importância desses processos para a prevenção de eventos adversos. Os estudantes reconheceram que a discussão coletiva sobre erros e a utilização de sistemas de notificação podem contribuir para melhorar a qualidade da assistência e prevenir novas falhas.

Entretanto, a interpretação do item relacionado ao conforto em relatar erros requer maior cautela. A média obtida (3,56) e a distribuição heterogênea das respostas indicam que a percepção dos estudantes não é uniforme. Enquanto alguns participantes demonstram sentir-se confortáveis para relatar erros aos professores, outros expressam neutralidade ou desconforto em relação a essa prática. Portanto, os resultados não permitem afirmar de forma generalizada que os estudantes não se sentem seguros para relatar erros, mas sugerem a presença de percepções variadas entre os participantes.

Essa heterogeneidade é consistente com achados da literatura recente, que indicam que estudantes de enfermagem frequentemente reconhecem a importância do reporte de eventos adversos, mas podem enfrentar barreiras relacionadas ao medo de julgamento, às relações hierárquicas ou à ausência de um ambiente psicologicamente seguro para a comunicação de erros (Bartoníčková et al., 2025).

Essa dinâmica também dialoga com a literatura sobre o fenômeno da segunda vítima, que descreve o impacto emocional vivenciado por profissionais ou estudantes envolvidos em eventos adversos. Pesquisas recentes mostram que sentimentos de culpa, ansiedade e medo de julgamento podem influenciar a disposição de estudantes para relatar erros ou discutir falhas ocorridas durante atividades clínicas (Catalán et al., 2024; Sahay; McKenna, 2023).

Outro resultado relevante do estudo foi a ausência de associação estatisticamente significativa entre os escores de percepção e as variáveis sociodemográficas analisadas. Esse achado sugere que a percepção sobre segurança do paciente pode estar mais relacionada às experiências educacionais compartilhadas durante a formação do que a características individuais dos estudantes. Revisões recentes indicam que fatores institucionais, como currículo, cultura organizacional e qualidade da supervisão clínica, exercem maior influência sobre a construção da cultura de segurança entre estudantes da área da saúde (Gore; Schrems, 2025).

De forma geral, os resultados deste estudo indicam que os estudantes reconhecem a relevância da segurança do paciente e demonstram compreensão conceitual consistente sobre o tema. Entretanto, persistem desafios relacionados à integração entre teoria e prática e à consolidação de ambientes de aprendizagem que favoreçam a comunicação aberta sobre erros e eventos adversos.

Como limitações do estudo, destacam-se a dificuldade de generalização dos resultados e comparação com diferentes modelos curriculares e realidades regionais do ensino de enfermagem no Brasil. Apesar da coleta de dados ter ocorrido de forma anônima, é possível que alguns estudantes tenham respondido sob efeito de um viés institucional ou de pertencimento. Além disso, o uso exclusivo de um questionário estruturado limita a exploração de percepções subjetivas, experiências individuais e nuances emocionais relacionadas à prática do estágio e à vivência de eventos adversos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este estudo permitiu compreender a percepção dos acadêmicos de Enfermagem acerca da segurança do paciente no contexto de seu processo formativo. De modo geral, os resultados evidenciaram que os estudantes reconhecem a segurança do paciente como um componente fundamental da assistência em saúde e demonstram compreensão satisfatória de seus conceitos centrais, especialmente no que se refere ao entendimento de que o erro não decorre exclusivamente de falha individual, mas pode estar relacionado à complexidade dos sistemas de cuidado, às condições de trabalho e aos fatores organizacionais envolvidos na prática assistencial.

Os achados também mostraram que os acadêmicos atribuem elevado valor formativo à discussão de erros em sala de aula e nos cenários de estágio, reconhecendo essa prática como importante para o aprimoramento do raciocínio crítico, da tomada de decisão e da qualificação do cuidado. Por outro lado, a percepção acerca da abordagem do tema ao longo da graduação mostrou-se heterogênea, sugerindo que, embora a segurança do paciente esteja presente no processo formativo, sua inserção pode não ocorrer de maneira uniforme, progressiva e transversal em todos os momentos da formação.

No âmbito da aplicação prática, observou-se que os estudantes percebem a relevância de adotar medidas de segurança durante os estágios, porém identificam fragilidades nos cenários de prática, especialmente quanto às condições do ambiente para a promoção de um cuidado seguro. Esse resultado indica que ainda há um descompasso entre o conhecimento construído no âmbito acadêmico e as possibilidades concretas de sua operacionalização nos serviços de saúde, o que reforça a necessidade de maior articulação entre ensino, supervisão e prática clínica.

Em relação à comunicação e à notificação de erros, os resultados apontaram percepção positiva sobre a importância desses processos para a prevenção de eventos adversos e para a melhoria da assistência. Contudo, o conforto para relatar erros aos professores não se mostrou homogêneo entre os participantes, evidenciando que a abertura ao diálogo e a segurança psicológica nos cenários formativos ainda se apresentam como aspectos a serem fortalecidos. Assim, a construção de uma cultura de segurança no processo de formação requer não apenas ensino conceitual, mas também ambientes pedagógicos e assistenciais que

favoreçam a comunicação aberta, o aprendizado com o erro e a reflexão crítica sobre a prática.

A ausência de associação estatisticamente significativa entre percepção e variáveis sociodemográficas sugere que a compreensão dos acadêmicos sobre segurança do paciente parece estar mais relacionada às experiências institucionais e educacionais compartilhadas do que a características individuais. Esse achado reforça o papel central das instituições formadoras e dos campos de estágio na consolidação de uma formação comprometida com a qualidade e a segurança da assistência.

Nesse sentido, conclui-se que a percepção dos acadêmicos de Enfermagem sobre a segurança do paciente é globalmente positiva e revela base conceitual consistente, valorização da discussão de erros e reconhecimento da importância da comunicação e da prevenção de eventos adversos. Entretanto, persistem desafios relacionados à integração longitudinal do tema no currículo, à transposição do conhecimento para a prática e à consolidação de ambientes de estágio mais favoráveis à segurança do paciente e ao aprendizado.

Quanto às contribuições da temática para a Enfermagem, este estudo reforça que a segurança do paciente deve ser compreendida como eixo estruturante da formação e da prática profissional, uma vez que está diretamente relacionada à qualidade do cuidado, à prevenção de danos, ao exercício ético da profissão e ao fortalecimento de uma cultura assistencial mais reflexiva, crítica e segura. Ao evidenciar potencialidades e fragilidades no processo formativo, a pesquisa contribui para subsidiar revisões curriculares, qualificar estratégias pedagógicas, fortalecer a supervisão nos estágios e estimular práticas educativas que aproximem teoria e prática. Além disso, oferece subsídios para que docentes, gestores acadêmicos e profissionais dos serviços de saúde repensem coletivamente a formação do enfermeiro, com vistas à preparação de profissionais mais conscientes, tecnicamente competentes e comprometidos com a segurança do paciente em todos os níveis de atenção.

Por fim, recomenda-se que estudos futuros ampliem a investigação para outras instituições e contextos regionais, bem como utilizem abordagens metodológicas complementares, a fim de aprofundar a compreensão das experiências, percepções e desafios vivenciados pelos estudantes de Enfermagem em sua formação para a segurança do paciente.

REFERÊNCIAS

- ADAMY, E. K. et al. Patient safety in nursing education: challenges and perspectives. *Revista Latino-Americana de Enfermagem*, Ribeirão Preto, v. 31, e3895, 2023. DOI: <https://doi.org/10.1590/1518-8345.0000.3895>. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rlae>. Acesso em: 14 jan. 2026.
- AL-NAWAFLEH, A. H. et al. Effectiveness of patient safety education among nursing students. *PLOS ONE*, 2024. DOI: <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0297432>. Disponível em: <https://journals.plos.org/plosone>. Acesso em: 14 jan. 2026.
- ALRASHEEDAY, A. M. et al. Patient safety education in undergraduate nursing curricula. *Nurse Education Today*, Amsterdam, 2025. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.nedt.2025.105687>. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/journal/nurse-education-today>. Acesso em: 14 jan. 2026.
- ALVES, D. F. B. et al. Cultura de segurança do paciente na perspectiva da equipe multiprofissional: uma revisão integrativa. *Revista de Pesquisa: Cuidado é Fundamental Online*, v. 13, p. 836-842, 2021. DOI: <https://doi.org/10.9789/2175-5361.rpcfo.v13.9235>. Disponível em: <https://seer.unirio.br/cuidadofundamental>. Acesso em: 14 jan. 2026.
- AURÉLIO. Percepção. *Dicionário Aurélio*, 2023. Disponível em: <https://www.aurelio.com.br/definicao/percepcao>. Acesso em: 14 jan. 2026.
- BARTONÍČKOVÁ, D. et al. Nursing students' perspectives on patient safety culture. *Journal of Clinical Nursing*, 2025. DOI: <https://doi.org/10.1111/jocn.17123>. Disponível em: <https://onlinelibrary.wiley.com/journal/13652702>. Acesso em: 14 jan. 2026.
- BOATENG, G. O. et al. Best practices for developing and validating scales for health research. *Frontiers in Public Health*, 2023. DOI: <https://doi.org/10.3389/fpubh.2023.1105738>. Disponível em: <https://www.frontiersin.org/journals/public-health>. Acesso em: 14 jan. 2026.
- BOHOMOL, E. Ensino sobre segurança do paciente em curso de graduação em enfermagem na perspectiva docente. *Escola Anna Nery*, v. 23, n. 2, 2019. DOI: <https://doi.org/10.1590/2177-9465-EAN-2018-0364>. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/ean>. Acesso em: 14 jan. 2026.
- BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria GM/MS nº 529, de 1º de abril de 2013. Institui o Programa Nacional de Segurança do Paciente. *Diário Oficial da União*, Brasília, 2013. Disponível em: <https://bvsms.saude.gov.br>. Acesso em: 14 jan. 2026.
- BRASIL. Ministério da Saúde. Programa Nacional de Segurança do Paciente (PNSP). Brasília: Ministério da Saúde, 2013. Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/programa_nacional_seguranca_paciente.pdf. Acesso em: 14 jan. 2026.
- BRASIL. Conselho Nacional de Educação. Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Enfermagem. Brasília: CNE, 2001. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br>. Acesso em: 14 jan. 2026.

BRASIL. Conselho Nacional de Educação. Proposta de atualização das Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Enfermagem. Brasília: CNE, 2024. Disponível em: <https://www.gov.br/mec>. Acesso em: 14 jan. 2026.

BUSCH, I. M. et al. The second victim phenomenon: a systematic review. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, Basel, v. 19, n. 21, 2022. DOI: <https://doi.org/10.3390/ijerph192114623>. Disponível em: <https://www.mdpi.com/1660-4601/19/21>. Acesso em: 14 jan. 2026.

CATALÁN, L. et al. Second victim phenomenon among healthcare students: a scoping review. *Nurse Education in Practice*, 2024. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.nepr.2024.103879>. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/journal/nurse-education-in-practice>. Acesso em: 14 jan. 2026.

GLARCHER, M. et al. Promoting just culture in nursing education. *Nurse Education Today*, 2025. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.nedt.2025.105694>. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/journal/nurse-education-today>. Acesso em: 14 jan. 2026.

GORE, J.; SCHREMS, B. Factors influencing patient safety culture among nursing students. *Journal of Advanced Nursing*, 2025. DOI: <https://doi.org/10.1111/jan.16348>. Disponível em: <https://onlinelibrary.wiley.com/journal/13652648>. Acesso em: 14 jan. 2026.

GRANADEIRO, L. et al. Clinical training and patient safety competencies among nursing students: a multicenter study. *Nurse Education Today*, v. 139, 2025. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.nedt.2025.105673>. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/journal/nurse-education-today>. Acesso em: 14 jan. 2026.

HULLEY, S. B. et al. *Designing Clinical Research*. 4. ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 2013. Disponível em: <https://books.google.com>. Acesso em: 14 jan. 2026.

INSTITUTE OF MEDICINE. *To Err is Human: Building a Safer Health System*. Washington: National Academy Press, 1999. DOI: <https://doi.org/10.17226/9728>. Disponível em: <https://nap.nationalacademies.org/catalog/9728/to-err-is-human-building-a-safer-health-system>. Acesso em: 14 jan. 2026.

JAVORNICKÁ, D. et al. Supervisory support and patient safety learning in clinical education. *Nurse Education in Practice*, 2024. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.nepr.2024.103821>. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/journal/nurse-education-in-practice>. Acesso em: 14 jan. 2026.

NORA, C. R. D. et al. Patient safety in nursing education: integrative review. *Nurse Education in Practice*, v. 59, 2022. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.nepr.2022.103262>. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/journal/nurse-education-in-practice>. Acesso em: 14 jan. 2026.

OKUYAMA, A.; WAGNER, C.; BIJNEN, B. Patient safety education in health professional curricula: a systematic review. *BMJ Open*, v. 13, 2023. DOI: <https://doi.org/10.1136/bmjopen-2022-067284>. Disponível em: <https://bmjopen.bmj.com>. Acesso em: 14 jan. 2026.

OSHODI, T. O. et al. Nursing students' perceptions of staffing and patient safety in clinical learning environments. *Nurse Education in Practice*, 2025. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.nepr.2025.103945>. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/journal/nurse-education-in-practice>. Acesso em: 14 jan. 2026.

PANAGIOTI, M. et al. Prevalence, severity, and nature of preventable patient harm across medical care settings: systematic review and meta-analysis. *BMJ*, v. 366, l4185, 2022. DOI: <https://doi.org/10.1136/bmj.l4185>. Disponível em: <https://www.bmj.com/content/366/bmj.l4185>. Acesso em: 14 jan. 2026.

RODZIEWICZ, T. L.; HOUSEMAN, B.; HIPSKIND, J. E. Medical error reduction and prevention. StatPearls Publishing, 2024. Disponível em: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK499956/>. Acesso em: 14 jan. 2026.

SAHAY, A.; MCKENNA, L. Nurses and nursing students as second victims. *Nursing Outlook*, 2023. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.outlook.2023.101892>. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/journal/nursing-outlook>. Acesso em: 14 jan. 2026.

SETIA, M. S. Methodology series module 3: cross-sectional studies. *Indian Journal of Dermatology*, 2022. DOI: https://doi.org/10.4103/ijd.IJD_403_21. Disponível em: <https://www.e-ijd.org>. Acesso em: 14 jan. 2026.

VINCENT, C.; AMALBERTI, R. *Safer Healthcare: Strategies for the Real World*. 2. ed. Cham: Springer, 2023. DOI: <https://doi.org/10.1007/978-3-030-99040-0>. Disponível em: <https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-030-99040-0>. Acesso em: 14 jan. 2026.

VON ELM, E. et al. The Strengthening the Reporting of Observational Studies in Epidemiology (STROBE) statement: updated guidelines. *Journal of Clinical Epidemiology*, 2023. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.jclinepi.2023.01.010>. Disponível em: <https://www.jclinepi.com>. Acesso em: 14 jan. 2026.

WACHTER, R. M. *Understanding Patient Safety*. New York: McGraw-Hill, 2010. Disponível em: <https://accessmedicine.mhmedical.com>. Acesso em: 14 jan. 2026.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. *Global patient safety action plan 2021–2030*. Geneva: WHO, 2022. Disponível em: <https://www.who.int/publications/i/item/9789240032705>. Acesso em: 14 jan. 2026.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. *Patient Safety: Global Progress Report 2023*. Geneva: WHO, 2023. Disponível em: <https://www.who.int/publications/i/item/9789240082243>. Acesso em: 14 jan. 2026.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. *Global report on infection prevention and control*. Geneva: WHO, 2024. Disponível em: <https://www.who.int/publications/i/item/9789240051164>. Acesso em: 14 jan. 2026.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. Global report on patient safety. Geneva: WHO, 2024. Disponível em: <https://www.who.int/publications>. Acesso em: 14 jan. 2026.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. State of the World's Nursing 2025. Geneva: WHO, 2025. Disponível em: <https://www.who.int/publications>. Acesso em: 14 jan. 2026.

APÊNDICES

APÊNDICE I

INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS

Antes de iniciar o questionário, solicitamos que você preencha algumas informações para a caracterização dos participantes. Informamos que todas as respostas são confidenciais e serão utilizadas apenas para fins de análise estatística da pesquisa.

Por favor, assinale a alternativa que melhor descreve seu perfil:

1. **Gênero:** () Feminino () Masculino () Outro () Prefiro não responder
2. **Idade:** () 18 a 21 anos () 22 a 25 anos () 26 a 29 anos () 30 anos ou mais
3. **Série:** () 3º ano () 4º ano () 5º ano

O questionário a seguir tem como objetivo avaliar a sua percepção sobre a segurança do paciente. Ele está dividido em quatro domínio: **Conhecimento, Abordagem no Processo de Ensino- Aprendizagem, Aplicação Prática e Atitudes, Cultura de Segurança, Feedback e Melhoria Contínua**. Cada pergunta deve ser respondida utilizando uma escala Likert, em que você deverá escolher uma das opções que melhor reflete sua opinião.

As opções de resposta são:

- 1: Discordo Totalmente
- 2: Discordo
- 3: Neutro
- 4: Concordo
- 5: Concordo Totalmente

Instruções: Leia cada afirmação com atenção e assinale a alternativa que melhor corresponde ao seu ponto de vista. Não há respostas certas ou erradas; o importante é a sua opinião sincera. Lembre-se de que suas respostas são anônimas e serão tratadas de forma confidencial.

Domínio 1: Conhecimento sobre Segurança do Paciente

1.1. A segurança do paciente pode ser definida como a eliminação total dos riscos que possam evoluir para um evento adverso durante a assistência à saúde.

- ☐ () Discordo Totalmente
- ☐ () Discordo
- ☐ () Neutro
- ☐ () Concordo
- ☐ () Concordo Totalmente

1.2. Eu compreendo o conceito de segurança do paciente e sua importância para o trabalho da equipe de enfermagem.

- ☐ () Discordo Totalmente
- ☐ () Discordo
- ☐ () Neutro
- ☐ () Concordo
- ☐ () Concordo Totalmente

1.3. A segurança do paciente refere-se à redução dos riscos de danos desnecessários, ao mínimo aceitável relacionado à assistência de saúde.

- ☐ () Discordo Totalmente
- ☐ () Discordo
- ☐ () Neutro
- ☐ () Concordo
- ☐ () Concordo Totalmente

1.4. Profissionais de saúde comprometidos com seu trabalho não cometem erros durante a prestação de cuidado.

- ☐ () Discordo Totalmente
- ☐ () Discordo
- ☐ () Neutro
- ☐ () Concordo
- ☐ () Concordo Totalmente

Domínio 2: Abordagem no Processo de Ensino- Aprendizagem

2.1. A segurança do paciente foi um tema recorrente nas aulas teóricas ao longo do curso.

- ☐ Discordo Totalmente
- ☐ Discordo
- ☐ Neutro
- ☐ Concordo
- ☐ Concordo Totalmente

2.2. A discussão sobre erros em sala de aula ou durante o estágio é importante para melhorar minha prática.

- ☐ Discordo Totalmente
- ☐ Discordo
- ☐ Neutro
- ☐ Concordo
- ☐ Concordo Totalmente

2.3. As atividades e simulação realística realizadas durante o curso, abordam os aspectos de segurança do paciente.

- ☐ Discordo Totalmente
- ☐ Discordo
- ☐ Neutro
- ☐ Concordo
- ☐ Concordo Totalmente

Domínio 3: Aplicação Prática e Atitudes

3.1. Eu aplico corretamente as medidas de segurança do paciente durante os estágios.

- ☐ Discordo Totalmente
- ☐ Discordo
- ☐ Neutro
- ☐ Concordo

☐ Concordo Totalmente

3.2. Os professores de estágio reforçaram a importância da segurança do paciente durante as atividades práticas.

☐ Discordo Totalmente

☐ Discordo

☐ Neutro

☐ Concordo

☐ Concordo Totalmente

3.3. O ambiente de estágio oferece condições adequadas para a promoção da segurança do paciente.

☐ Discordo Totalmente

☐ Discordo

☐ Neutro

☐ Concordo

☐ Concordo Totalmente

Domínio 4: Cultura de Segurança, Feedback e Melhoria Contínua

4.1. Considero que os sistemas de notificações de eventos/erros contribui para a prevenção de novos eventos/erros.

☐ Discordo Totalmente

☐ Discordo

☐ Neutro

☐ Concordo

☐ Concordo Totalmente

4.2. Acredito que todos os profissionais envolvidos devem participar de discussões sobre a ocorrência de eventos adversos.

☐ Discordo Totalmente

☐ Discordo

☐ Neutro

☐ Concordo

☐ Concordo Totalmente

4.3. Sinto-me confortável em relatar erros que ocorrem durante os estágios aos professores.

☐ Discordo Totalmente

☐ Discordo

☐ Neutro

☐ Concordo

☐ Concordo Totalmente

4.4. Após identificar um erro, os professores promovem discussões sobre as causas e as melhores estratégias para evitá-lo no futuro.

☐ Discordo Totalmente

☐ Discordo

☐ Neutro

☐ Concordo

☐ Concordo Totalmente

APÊNDICE II

FREQUÊNCIAS DOS NÍVEIS DE RESPOSTA

Tabela 4: Domínio 1 (N e %).

Variável	Níveis	(N)	(%)
1.1 - A segurança do paciente pode ser definida como a eliminação total dos riscos que possam evoluir para um evento adverso durante a assistência à saúde	Concordo	26	66,67%
1.1 - A segurança do paciente pode ser definida como a eliminação total dos riscos que possam evoluir para um evento adverso durante a assistência à saúde	Concordo	6	15,38%
	Totalmente		
1.1 - A segurança do paciente pode ser definida como a eliminação total dos riscos que possam evoluir para um evento adverso durante a assistência à saúde	Discordo	3	7,69%
1.1 - A segurança do paciente pode ser definida como a eliminação total dos riscos que possam evoluir para um evento adverso durante a assistência à saúde	Discordo	1	2,56%
	Totalmente		
1.1 - A segurança do paciente pode ser definida como a eliminação total dos riscos que possam evoluir para um evento adverso durante a assistência à saúde	Neutro	3	7,69%
1.2 - Eu compreendo o conceito de segurança do paciente e sua importância para o trabalho da equipe de enfermagem	Concordo	25	64,10%
1.2 - Eu compreendo o conceito de segurança do paciente e sua importância para o trabalho da equipe de enfermagem	Concordo	12	30,77%
	Totalmente		
1.2 - Eu compreendo o conceito de segurança do paciente e sua importância para o trabalho da equipe de enfermagem	Neutro	2	5,13%
1.3 - A segurança do paciente refere-se à redução dos riscos de danos desnecessários, ao mínimo aceitável relacionado à assistência de saúde	Concordo	19	48,72%
1.3 - A segurança do paciente refere-se à redução dos riscos de danos desnecessários, ao mínimo aceitável relacionado à assistência de saúde	Concordo	15	38,46%
	Totalmente		

Variável	Níveis	(N)	(%)
1.3 - A segurança do paciente refere-se à redução dos riscos de danos desnecessários, ao mínimo aceitável relacionado à assistência de saúde	Discordo	1	2,56%
1.3 - A segurança do paciente refere-se à redução dos riscos de danos desnecessários, ao mínimo aceitável relacionado à assistência de saúde	Discordo	1	2,56%
1.3 - A segurança do paciente refere-se à redução dos riscos de danos desnecessários, ao mínimo aceitável relacionado à assistência de saúde	Totalmente		
1.3 - A segurança do paciente refere-se à redução dos riscos de danos desnecessários, ao mínimo aceitável relacionado à assistência de saúde	Neutro	3	7,69%
1.4 - Profissionais de saúde comprometidos com seu trabalho não cometem erros durante a prestação de cuidado	Concordo	5	12,82%
1.4 - Profissionais de saúde comprometidos com seu trabalho não cometem erros durante a prestação de cuidado	Discordo	22	56,41%
1.4 - Profissionais de saúde comprometidos com seu trabalho não cometem erros durante a prestação de cuidado	Discordo	6	15,38%
1.4 - Profissionais de saúde comprometidos com seu trabalho não cometem erros durante a prestação de cuidado	Totalmente		
1.4 - Profissionais de saúde comprometidos com seu trabalho não cometem erros durante a prestação de cuidado	Neutro	6	15,38%

Tabela 5: Domínio 2 (N e %).

Variável	Níveis	(N)	(%)
2.1 - A segurança do paciente foi um tema recorrente nas aulas teóricas ao longo do curso	Concordo	24	61,54%
2.1 - A segurança do paciente foi um tema recorrente nas aulas teóricas ao longo do curso	Concordo	6	15,38%
2.1 - A segurança do paciente foi um tema recorrente nas aulas teóricas ao longo do curso	Totalmente		
2.1 - A segurança do paciente foi um tema recorrente nas aulas teóricas ao longo do curso	Discordo	4	10,26%
2.1 - A segurança do paciente foi um tema recorrente nas aulas teóricas ao longo do curso	Neutro	5	12,82%
2.2 - A discussão sobre erros em sala de aula ou durante o estágio é importante para melhorar minha prática	Concordo	13	33,33%

Variável	Níveis	(N)	(%)
2.2 - A discussão sobre erros em sala de aula ou durante o estágio é importante para melhorar minha prática	Concordo	26	66,67%
	Totalmente		
2.3 - As atividades e simulação realística realizadas durante o curso, abordam os aspectos de segurança do paciente	Concordo	15	38,46%
2.3 - As atividades e simulação realística realizadas durante o curso, abordam os aspectos de segurança do paciente	Concordo	12	30,77%
	Totalmente		
2.3 - As atividades e simulação realística realizadas durante o curso, abordam os aspectos de segurança do paciente	Discordo	1	2,56%
2.3 - As atividades e simulação realística realizadas durante o curso, abordam os aspectos de segurança do paciente	Discordo	1	2,56%
	Totalmente		
2.3 - As atividades e simulação realística realizadas durante o curso, abordam os aspectos de segurança do paciente	Neutro	10	25,64%

Tabela 6: Domínio 3 (N e %).

Variável	Níveis	(N)	(%)
3.1 - Eu aplico corretamente as medidas de segurança do paciente durante os estágios	Concordo	25	64,10%
3.1 - Eu aplico corretamente as medidas de segurança do paciente durante os estágios	Concordo	7	17,95%
	Totalmente		
3.1 - Eu aplico corretamente as medidas de segurança do paciente durante os estágios	Neutro	7	17,95%
3.2 - Os professores de estágio reforçaram a importância da segurança do paciente durante as atividades práticas	Concordo	27	69,23%
3.2 - Os professores de estágio reforçaram a importância da segurança do paciente durante as atividades práticas	Concordo	10	25,64%
	Totalmente		
3.2 - Os professores de estágio reforçaram a importância da segurança do paciente durante as atividades práticas	Neutro	2	5,13%
3.3 - O ambiente de estágio oferece condições adequadas para a promoção da segurança do paciente	Concordo	12	30,77%

Variável	Níveis	(N)	(%)
3.3 - O ambiente de estágio oferece condições adequadas para a promoção da segurança do paciente	Concordo	2	5,13%
	Totalmente		
3.3 - O ambiente de estágio oferece condições adequadas para a promoção da segurança do paciente	Discordo	12	30,77%
3.3 - O ambiente de estágio oferece condições adequadas para a promoção da segurança do paciente	Discordo	2	5,13%
	Totalmente		
3.3 - O ambiente de estágio oferece condições adequadas para a promoção da segurança do paciente	Neutro	11	28,21%

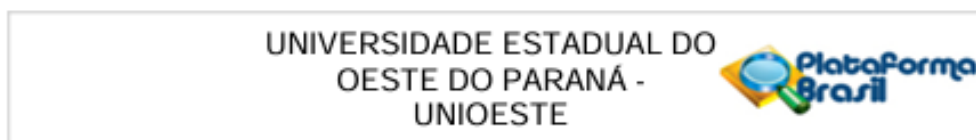
Tabela 7: Domínio 4 (N e %)

Variável	Níveis	(N)	(%)
4.1 - Considero que os sistemas de notificações de eventos/erros contribuem para a prevenção de novos eventos/erros	Concordo	16	41,03%
4.1 - Considero que os sistemas de notificações de eventos/erros contribuem para a prevenção de novos eventos/erros	Concordo	17	43,59%
	Totalmente		
4.1 - Considero que os sistemas de notificações de eventos/erros contribuem para a prevenção de novos eventos/erros	Discordo	1	2,56%
4.1 - Considero que os sistemas de notificações de eventos/erros contribuem para a prevenção de novos eventos/erros	Neutro	5	12,82%
4.2 - Acredito que todos os profissionais envolvidos devem participar de discussões sobre a ocorrência de eventos adversos	Concordo	19	48,72%
4.2 - Acredito que todos os profissionais envolvidos devem participar de discussões sobre a ocorrência de eventos adversos	Concordo	20	51,28%
	Totalmente		
4.3 - Sinto-me confortável em relatar erros que ocorrem durante os estágios aos professores	Concordo	13	33,33%
4.3 - Sinto-me confortável em relatar erros que ocorrem durante os estágios aos professores	Concordo	9	23,08%
	Totalmente		

Variável	Níveis	(N)	(%)
4.3 - Sinto-me confortável em relatar erros que ocorrem durante os estágios aos professores	Discordo	7	17,95%
4.3 - Sinto-me confortável em relatar erros que ocorrem durante os estágios aos professores	Discordo	1	2,56%
	Totalmente		
4.3 - Sinto-me confortável em relatar erros que ocorrem durante os estágios aos professores	Neutro	9	23,08%
4.4 - Após identificar um erro, os professores promovem discussões sobre as causas e as melhores estratégias para evitá-lo no futuro	Concordo	25	64,10%
4.4 - Após identificar um erro, os professores promovem discussões sobre as causas e as melhores estratégias para evitá-lo no futuro	Concordo	2	5,13%
	Totalmente		
4.4 - Após identificar um erro, os professores promovem discussões sobre as causas e as melhores estratégias para evitá-lo no futuro	Discordo	3	7,69%
4.4 - Após identificar um erro, os professores promovem discussões sobre as causas e as melhores estratégias para evitá-lo no futuro	Discordo	1	2,56%
	Totalmente		
4.4 - Após identificar um erro, os professores promovem discussões sobre as causas e as melhores estratégias para evitá-lo no futuro	Neutro	8	20,51%

ANEXOS

ANEXO A - Parecer Consubstanciado do Comitê de Ética em Pesquisa



PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP

DADOS DO PROJETO DE PESQUISA

Título da Pesquisa: Percepção do acadêmico de enfermagem sobre a temática da segurança do paciente

Pesquisador: Reinaldo Antonio da Silva Sobrinho

Área Temática:

Versão: 1

CAAE: 88097325.0.0000.0107

Instituição Proponente: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ

Patrocinador Principal: Financiamento Próprio

DADOS DO PARECER

Número do Parecer: 7.610.530

Apresentação do Projeto:

Projeto de Mestrado que busca investigar a percepção de acadêmicas/os de Graduação em Enfermagem sobre a temática da segurança do paciente, cuja pesquisa será conduzida no campus da Unioeste no município de Foz do Iguaçu/PR, tendo como participantes os estudantes matriculados nos últimos 3 anos do curso.

Apresenta-se bem estruturado, com a problemática apresentada na introdução, hipótese delimitada, justificativa e relevância do estudo, objetivos delimitados, passíveis de serem alcançados de acordo com a metodologia e o cronograma de atividades apresentado.

Descreve detalhadamente a forma de coleta e análise dos dados, critérios de inclusão e exclusão de participantes, assim como apresenta os termos de apresentação obrigatória necessários a apreciação deste CEP, estando em conformidade com as normas regulamentadoras de pesquisa com seres humanos.

Objetivo da Pesquisa:

OBJETIVO GERAL

Avaliar a percepção do acadêmico de enfermagem sobre a temática da segurança do paciente,

Endereço: RUA UNIVERSITARIA 1619

Bairro: UNIVERSITARIO

UF: PR

Município: CASCAVEL

Telefone: (45)3220-3092

CEP: 85.819-110

E-mail: cep.prpgg@unioeste.br

**UNIVERSIDADE ESTADUAL DO
OESTE DO PARANÁ -
UNIOESTE**



Continuação do Parecer: 7.610.530

relacionada ao processo de ensino-aprendizagem.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Avaliar o entendimento dos acadêmicos de enfermagem sobre o significado de segurança do paciente;

Verificar se a temática da segurança do paciente é abordada pelos professores durante o processo de ensino-aprendizagem;

Analisar se os acadêmicos de enfermagem aplicam os conhecimentos sobre segurança do paciente nos estágios supervisionados e em suas atividades práticas;

Analisar se os acadêmicos de enfermagem reconhecem a importância da comunicação efetiva e da identificação precoce de erros, como estratégias essenciais para promover um cuidado mais seguro e prevenir eventos adversos.

Avaliação dos Riscos e Benefícios:

Em conformidade

Riscos:

Esta pesquisa apresenta riscos mínimos aos participantes, uma vez que consiste na aplicação de um questionário estruturado, que não envolve intervenções diretas ou coleta de dados sensíveis. O risco está relacionado ao desconforto ou reflexão crítica que as perguntas podem gerar, especialmente ao abordar questões ligadas à segurança do paciente e a vivências práticas durante a formação. No entanto, esses riscos serão mitigados garantindo o anonimato das respostas e deixando claro que os participantes podem desistir a qualquer momento, sem qualquer prejuízo ou necessidade de justificativa.

Benefícios:

Para os participantes, a reflexão provocada pelo questionário pode contribuir para ampliar sua consciência sobre a importância da segurança do paciente e incentivá-los a integrar esse conceito em suas práticas futuras. Para a comunidade acadêmica, os resultados da pesquisa podem fornecer informações valiosas sobre as percepções dos estudantes, evidenciando possíveis lacunas nos currículos de enfermagem e propondo caminhos para melhorias de todo o processo de ensino aprendizagem. Além disso, os benefícios se estendem ao campo da assistência em saúde. Ao compreender melhor como a segurança do paciente é percebida

Endereço: RUA UNIVERSITARIA 1619
Bairro: UNIVERSITARIO
UF: PR **Município:** CASCAVEL
Telefone: (45)3220-3092

CEP: 85.819-110

E-mail: cep.prppg@unioeste.br

**UNIVERSIDADE ESTADUAL DO
OESTE DO PARANÁ -
UNIOESTE**



Continuação do Parecer: 7.610.530

pelos futuros enfermeiros, será possível sugerir estratégias que fortaleçam a formação profissional, contribuindo para a construção de práticas mais seguras e eficazes. Assim, a pesquisa não apenas enriquece o conhecimento acadêmico, mas também tem o potencial de gerar impacto positivo na qualidade do cuidado prestado à sociedade

Comentários e Considerações sobre a Pesquisa:

Trata-se de um estudo com abordagem descritiva e caráter quantitativo, a ser realizada na Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste), no curso de graduação em Enfermagem, no Campus de Foz do Iguaçu/PR. Os participantes serão estudantes do curso de Enfermagem que estejam cursando o 3º, 4º e 5º anos, considerando sua vivência prática em estágios supervisionados.

A coleta de dados será feita por meio de um questionário estruturado, composto por questões fechadas e validadas previamente por um painel de especialistas em segurança do paciente.

Os questionários serão aplicados de forma presencial, cujo planejamento desta etapa privilegiou o cumprimento do calendário acadêmico, havendo a supervisão de um membro da equipe de pesquisa para esclarecer possíveis dúvidas dos participantes.

Os dados coletados serão organizados e analisados por meio de técnicas estatísticas descritivas, utilizando softwares adequados para o tratamento das informações. Os resultados serão apresentados em tabelas e gráficos, mostrando frequências e percentuais das respostas, além de identificar possíveis padrões na percepção dos estudantes sobre a segurança do paciente. Análises adicionais poderão ser realizadas para explorar variáveis como gênero, idade ou experiências práticas, oferecendo uma compreensão mais detalhada e abrangente dos fatores que influenciam essa percepção.

Critérios de Inclusão: Serão incluídos na pesquisa os estudantes regularmente matriculados no 3º, 4º ou 5º ano do curso de graduação em Enfermagem, que concordarem em participar do estudo por meio da assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE).

Critérios de Exclusão: Serão excluídos da pesquisa os estudantes que, mesmo atendendo aos critérios de inclusão, não estiverem presentes no dia da coleta de dados, apresentarem justificativas de saúde, estiverem afastados das atividades acadêmicas ou enfrentarem qualquer circunstância que dificulte sua participação voluntária no momento da aplicação do

Endereço: RUA UNIVERSITÁRIA 1619

Bairro: UNIVERSITÁRIO

UF: PR

Telefone: (45)3220-3092

Município: CASCAVEL

CEP: 85.819-110

E-mail: cep.prppg@unioeste.br

**UNIVERSIDADE ESTADUAL DO
OESTE DO PARANÁ -
UNIOESTE**



Continuação do Parecer: 7.610.530

instrumento.

Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória:

Anexo I - Formulário de pesquisa - anexado

Anexo II - Autorização da instituição co-participante - não anexado, porém justificado e em conformidade

Anexo III - Declaração de uso de dados - anexado

Anexo IV - Declaração de pesquisa não iniciada - anexada

Folha de Rosto - anexada

Projeto de Pesquisa - anexado

Instrumento de coleta de dados - anexado

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) - anexado

Recomendações:

Apresentar relatório final da pesquisa a este CEP em até 30 dias após o término da mesma.

Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações:

Sem pendências.

Considerações Finais a critério do CEP:

O pesquisador deverá entregar o relatório Final, assim que concluir o estudo. A desistência do estudo ou qualquer alteração ocorrida deverá ser comunicada, por emenda, apensada na Plataforma Brasil.

Este parecer foi elaborado baseado nos documentos abaixo relacionados:

Tipo Documento	Arquivo	Postagem	Autor	Situação
Informações Básicas do Projeto	PB_INFORMAÇÕES_BÁSICAS_DO_PROJETO_2461470.pdf	24/04/2025 13:55:29		Aceito

Endereço: RUA UNIVERSITARIA 1619

Bairro: UNIVERSITARIO

CEP: 85.819-110

UF: PR

Município: CASCAVEL

Telefone: (45)3220-3092

E-mail: cep.prppg@unioeste.br

**UNIVERSIDADE ESTADUAL DO
OESTE DO PARANÁ -
UNIOESTE**



Continuação do Parecer: 7.610.530

Outros	justificativa.pdf	24/04/2025 13:55:05	Ana Caroline Maes Carrasco	Aceito
Projeto Detalhado / Brochura Investigador	projeto.pdf	24/04/2025 13:53:11	Ana Caroline Maes Carrasco	Aceito
Cronograma	cronograma.pdf	24/04/2025 13:52:27	Ana Caroline Maes Carrasco	Aceito
Outros	Instrumento_coleta_dados.pdf	14/04/2025 08:23:43	Ana Caroline Maes Carrasco	Aceito
TCLE / Termos de Assentimento / Justificativa de Ausência	TCLE_ANA_CARRASCO.pdf	14/04/2025 08:22:47	Ana Caroline Maes Carrasco	Aceito
Solicitação registrada pelo CEP	Formulario_CEP_Ana_Carrasco.pdf	14/04/2025 08:22:01	Ana Caroline Maes Carrasco	Aceito
Folha de Rosto	reinaldo.pdf	23/01/2025 14:53:52	Ana Caroline Maes Carrasco	Aceito

Situação do Parecer:

Aprovado

Necessita Apreciação da CONEP:

Não

CASCADEL, 01 de Junho de 2025

Assinado por:

**Franciele Foschiera Camboin
(Coordenador(a))**

Endereço: RUA UNIVERSITARIA 1619

Bairro: UNIVERSITARIO

CEP: 85.819-110

UF: PR

Município: CASCADEL

Telefone: (45)3220-3092

E-mail: cep.prppg@unioeste.br